

Anlagenkonvolut zum Kurzprotokoll der 8. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit am 8. Oktober 2025

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.



Bundesrechnungshof • Adenauerallee 81 • 53113 Bonn

Nur per E-Mail

IX 1 - 0002760

15. August 2025

Frau

Lisa Paus, MdB

Amtierende Vorsitzende
des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages

nachrichtlich:

Frau

Dr. Tanja Machalet, MdB

Vorsitzende
des Gesundheitsausschusses
des Deutschen Bundestages

Frau

Kerstin Radomski, MdB

Vorsitzende
des Rechnungsprüfungsausschusses
des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages

Herrn

Björn Wolf

Büroleiter
beim Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestages

Herrn

Dr. Alexander Troche

Sekretariatsleiter
beim Rechnungsprüfungsausschuss
des Haushaltsausschusses
des Deutschen Bundestages

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Bundesrechnungshof
Adenauerallee 81
53113 Bonn

Telefon 0228 99 721-0
poststelle@brh.bund.de
www.bundesrechnungshof.de

Außenstelle Berlin
Friedrichstraße 130 B
10117 Berlin

Außenstelle Potsdam
Dortustraße 30-33
14467 Potsdam



haushaltsausschuss@bundestag.de

HHA-Drucksachen@bundestag.de

rechnungspruefungsausschuss@bundestag.de

**Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zur
Entwicklung der Finanzlage in der gesetzlichen Krankenversicherung**

Anlage: - 1 -

Sehr geehrte Frau Abgeordnete,

als Anlage übersenden wir unseren Bericht über die Entwicklung der Finanzlage in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Die Stellungnahme des Bundesministeriums für Gesundheit zum Entwurf des Berichts haben wir berücksichtigt.

Wir weisen darauf hin, dass wir beabsichtigen, den Bericht nach Abschluss der parlamentarischen Beratungen zu veröffentlichen.

Für Ihre Fragen oder ein Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Weber

Sievers

Prüfungsschwerpunkt

Resilienz der staatlichen Kernfunktionen und ihrer kritischen Infrastruktur

→ *Gesundheit*

Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO
an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages

Entwicklung der Finanzlage in der gesetzlichen Krankenversicherung

15. August 2025

Geschäftszeichen: IX 1 - 0002760

Dieser Bericht enthält das vom Bundesrechnungshof abschließend im Sinne des § 96 Absatz 4 BHO festgestellte Prüfungsergebnis. Eine Weitergabe an Dritte ist erst möglich, wenn der Bericht vom Parlament abschließend beraten wurde. Die Entscheidung über eine Weitergabe bleibt dem Bundesrechnungshof vorbehalten.

Dieser Bericht des Bundesrechnungshofes ist urheberrechtlich geschützt. Eine Veröffentlichung ist nicht zulässig.

Finanzen der Krankenkassen massiv unter Druck – Gesundheitssystem muss reformiert werden

Die Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) spitzt sich zu. Die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben wächst jährlich um 6 bis 8 Mrd. Euro. Bis zum Jahr 2029 könnte der Zusatzbeitrag auf 4,05 % steigen. Dies dämpft das Wirtschaftswachstum. Der Bund will eine Expertenkommission einrichten und schiebt notwendige Schritte auf die lange Bank.

→ Worum geht es?

Die GKV verzeichnete 2024 ein Defizit von 6,6 Mrd. Euro. Der Ausgabenanstieg war der höchste der letzten 30 Jahre. Dazu trugen neben dem technischen Fortschritt und der demographischen Entwicklung vor allem gesetzliche Leistungsausweitungen bei. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Die Rücklagen der Krankenkassen sind aufgezehrt und sichern keine ausreichende Beitragsstabilität. Die Mindestreserve des Gesundheitsfonds ist zu niedrig und gefährdet die Zahlungen an die Krankenkassen.

→ Was ist zu tun?

Es ist zügig ein Gesamtkonzept zur Stabilisierung der GKV zu erarbeiten und mit Einsparzielen zu unterlegen. Mit strukturellen Reformen sind langfristig Effizienzreserven im Gesundheitswesen zu heben.

→ Was ist das Ziel?

Die GKV ist ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Gesundheitswesens. Die Stärkung ihrer finanziellen Situation dient der Stabilisierung einer staatlichen Kernfunktion und sichert die Handlungsfähigkeit in künftigen Krisen.

Inhaltsverzeichnis

0	Zusammenfassung	6
1	Vorbemerkung	10
2	Thematische Einführung	11
2.1	Gesundheitsfonds	11
2.2	Zusatzbeitragssatz	13
2.3	Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds	14
2.4	Finanzreserven der Krankenkassen	15
3	Finanzielle Entwicklung der GKV	16
3.1	Stabilisierung des Zusatzbeitragssatzes	16
3.2	Entwicklung der Liquiditätsreserve	19
3.3	Entwicklung der Finanzreserven	21
3.4	Rechnungsergebnis der Krankenkassen im Jahr 2024	23
3.5	Künftige Entwicklung	24
4	Vorläufige Würdigung	26
4.1	Stabilisierung der GKV ist unabdingbar	26
4.2	Mindestreserve des Gesundheitsfonds ist zu niedrig	28
4.3	Mindestrücklagen der Krankenkassen zu gering bemessen	28
5	Stellungnahme des BMG	29
5.1	Mittel- bis langfristige Finanzprognosen sind unsicher	29
5.2	Finanzstabilisierung im Koalitionsvertrag vereinbart	30
5.3	Gesetzliche Anpassungen werden geprüft	30
6	Abschließende Würdigung	31
6.1	GKV-Finzen stehen massiv unter Druck	31
6.2	Mindestreserve des Gesundheitsfonds anheben	32
6.3	Mindestrücklagen der Krankenkassen und Obergrenzen erhöhen	32
7	Fazit	33

Abkürzungsverzeichnis

B

BAS *Bundesamt für Soziale Sicherung*

BMF *Bundesministerium der Finanzen*

BMG *Bundesministerium für Gesundheit*

G

GKV *Gesetzliche Krankenversicherung*

GKV-Finanzstabilisierungsgesetz *Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung*

GKV-Spitzenverband *Spitzenverband Bund der Krankenkassen*

K

KHG *Krankenhausfinanzierungsgesetz*

KHVVG *Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen*

L

Liquiditätsreserve *Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds*

S

SGB V *Fünftes Buch Sozialgesetzbuch*

SVR *Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege*

0 Zusammenfassung

Der Bundesrechnungshof prüft in einem mehrjährigen Prüfungsschwerpunkt die Resilienz der staatlichen Kernfunktionen und ihrer kritischen Infrastruktur, insbesondere in den Sektoren Verkehr, Energie, Cybersicherheit, Kommunikation, innere- und äußere Sicherheit, Katastrophen- und Zivilschutz, Gesundheit, Wasser, Ernährung und Finanzen.

Resilienz versteht der Bundesrechnungshof insoweit umfassend als die Fähigkeit, staatliche Kernfunktionen und ihre kritische Infrastruktur zu schützen und einen funktionseinschränkenden Vorfall zu verhindern (präventive Komponente) sowie ursachenunabhängig im Falle eines funktionseinschränkenden Vorfalls auf diesen angemessen zu reagieren, diesen abzuwehren, seine negativen Folgen zu begrenzen sowie die Funktionsfähigkeit der betroffenen staatlichen Kernfunktionen und ihrer Infrastruktur möglichst zügig und umfassend wiederherzustellen (reaktive Komponente).

Vorliegend hat der Bundesrechnungshof die Entwicklung der Finanzlage in der gesetzlichen Krankenversicherung betrachtet. Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag stieg im Jahr 2025 um knapp andert-halb Prozentpunkte auf 42,3 %. Allein die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) verzeichnete einen Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes um 0,8 Prozentpunkte. Angesichts dieser finanziellen Dimensionen und ihrer Auswirkungen auf die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler sowie auf den Bundeshaushalt sieht sich der Bundesrechnungshof veranlasst, dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages über seine Feststellungen zu berichten.

0.1

Der Gesetzgeber beschloss seit dem Jahr 2020 wiederholt Maßnahmen zur Stabilisierung der Zusatzbeitragssätze. Im November 2022 trug er dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) auf, bis 31. Mai 2023 Empfehlungen für eine stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der GKV zu erarbeiten. Insbesondere sollte auch die Ausgabenseite betrachtet werden. Die Empfehlungen legte das BMG mehr als sieben Monate zu spät vor. Eine kurzfristige Stabilisierung wurde damit vereitelt. Inhaltlich blieben die Empfehlungen weit hinter den Erwartungen zurück. Darin beschriebene Strukturreformen, die mittel- bis langfristig wirken sollten (z. B. im Krankenhausbereich), waren nicht mit konkreten Einsparzielen hinterlegt. Vom BMG in den Blick genommene Elemente wie die Notfallreform und eine Dynamisierung des Bundeszuschusses und der Beiträge für Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger wurden bis heute nicht umgesetzt. (Textnummern 3.1, 4.1)

0.2

Krankenkassen verzeichneten im Jahr 2024 ein Defizit von 6,6 Mrd. Euro, das insbesondere auf gestiegene Leistungsausgaben zurückzuführen ist. Mit 8,2 % wuchsen die Leistungsausgaben gegenüber dem Vorjahr stärker als in jedem anderem Jahr der vergangenen drei Jahrzehnte. Zukünftig stehen ständig steigenden Ausgaben der GKV deutlich geringere Zuwächse bei den Einnahmen gegenüber. Die daraus folgende strukturelle Deckungslücke wächst jährlich um 6 bis 8 Mrd. Euro. Dies hätte einen Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes von 0,3 Beitragssatzpunkten pro Jahr zur Folge. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz liegt im Jahr 2025 bei 2,5 %. Er ist damit seit dem Jahr 2015 von 0,9 % um 1,6 Beitragssatzpunkte gestiegen. Das BMG rechnet in einer Prognose aus dem Frühjahr 2025 mit einem weiter steigenden durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz. Bis zum Jahr 2029 schätzt es in einem mittleren Szenario einen Anstieg auf 4,05 %. Die Finanzsituation der GKV belastet zunehmend Beitragszahlerinnen und Beitragszahler sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. (Textnummern 3.4, 3.5, 4.1, 6.1)

0.3

Die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds betrug zum Ende des Auszahlungsjahres 2024 5,7 Mrd. Euro. Zum Ende des Auszahlungsjahres 2025 ist eine Mindestreserve von 4,9 Mrd. Euro vorzuhalten. Die Liquiditätsreserve soll das Einnahmerisiko aufgrund unerwarteter konjunktureller Einbrüche und weiterer Faktoren absichern. Der Bundesrechnungshof betrachtet die Höhe der Mindestreserve als zu niedrig bemessen. Der notwendige Zahlungsfluss der Zuweisungen an die Krankenkassen wird hierdurch gefährdet. (Textnummern 3.2, 4.2, 6.2)

0.4

Die Finanzreserven der Krankenkassen sanken seit dem Jahr 2018 deutlich. Ende des Jahres 2024 betrugen sie nur noch 6 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe und unterschritten die gesetzliche Mindestrücklage von 20 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe deutlich. Der GKV-Spitzenverband hält den finanziellen Spielraum zum Ausgleich von Einnahmen- und Ausgabenschwankungen für nicht mehr ausreichend. Unterjährig hoben im Jahr 2024 34 Krankenkassen ihre Zusatzbeitragssätze an, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Über 60 % der Krankenkassen, die unterjährig ihren Zusatzbeitragssatz anheben mussten, verfügten Ende des Jahres 2023 noch über Finanzreserven von über 20 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe. Bis 1. Juli 2025 erhöhten 15 Krankenkassen unterjährig die Zusatzbeitragssätze. Weitere Anhebungen sind nicht ausgeschlossen.

Neben der Mindestrücklage ist auch die Obergrenze der Finanzreserven gesetzlich geregelt, die Obergrenze beträgt 50 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe. Der Bundesrechnungshof bewertet die von den Krankenkassen vorzuhaltende Mindestrücklage und die

Obergrenze der Finanzreserven als zu niedrig. Die Finanzreserven sollten auch bei unvorhersehbaren Ausgabenschwankungen unterjährige Zusatzbeitragssatzerhöhungen möglichst vermeiden. Die Bemessung der Finanzreserven muss Krankenkassen einen hinreichenden Spielraum für Investitionen erlauben und gleichzeitig die Leistungsausgaben absichern. Bei dem derzeit geltenden Abstand von nur 30 Prozentpunkten zwischen Mindestrücklage und Obergrenze ist dies nicht sichergestellt. (Textnummern 3.3, 4.3, 6.3)

0.5

Das BMG hat darauf hingewiesen, dass mittel- bis langfristige Finanzprognosen in der GKV in hohem Maße von den unterstellten Annahmen abhängig und daher mit erheblichen Unsicherheiten behaftet seien. Dies gelte besonders für die demografische Entwicklung, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Ausgabenentwicklung. Der Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode sehe vor, die Finanzsituation der GKV zu stabilisieren. Dazu solle ein Gesamtpaket aus strukturellen Anpassungen und kurzfristigen Maßnahmen beschlossen werden. Eine Kommission unter Beteiligung von Expertinnen und Experten und Sozialpartnern solle konkrete Maßnahmen zur langfristigen Stabilisierung der Beiträge erarbeiten und bis Frühjahr 2027 – gegebenenfalls schon früher – vorlegen.

Das BMG hat die Zweifel an einer ausreichenden Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds geteilt. Es will eine Erhöhung der Mindestreserve prüfen. Den Spielraum zwischen Mindestrücklage und Obergrenze hat das BMG als ausreichend betrachtet. Krankenkassen stünden durchschnittlich 0,45 Zusatzbeitragssatzpunkte zum Ausgleich der Effekte zur Verfügung. Trotzdem werde es die Anhebung der Höhe der Mindestrücklage und der Obergrenze der Finanzreserven prüfen. (Textnummer 5)

0.6

Der Bundesrechnungshof erkennt die bestehenden Unsicherheiten bei der Finanzprognose der GKV ausdrücklich an. Einigkeit besteht aber hinsichtlich der besonderen Dynamik: Die Ausgaben steigen erheblich schneller als die Einnahmen, was zu einer jährlich wachsenden strukturellen Deckungslücke führt. Wissenschaftliche Analysen bestätigen diese Entwicklung. Das BMG hat die Chance vertan, frühzeitig auf die Beitragssatzentwicklung zu reagieren. Die GKV ist ein integraler Bestandteil des deutschen Gesundheitswesens. Die Stärkung ihrer finanziellen Situation dient der Stabilisierung einer staatlichen Kernfunktion und sichert die Handlungsfähigkeit in künftigen Krisen. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel der Stabilisierung der Finanzsituation der GKV und ihrer Beiträge wird vom Bundesrechnungshof begrüßt. Durch die Vorlage der Kommissions-Ergebnisse im Frühjahr 2027 könnten gesetzgeberische Maßnahmen aber realistischerweise erst ab dem Jahr 2028 greifen und Wirkung zeigen. Das strukturelle Defizit würde bis dahin voraussichtlich um weitere 12 bis 16 Mrd. Euro anwachsen. Der Bundesrechnungshof hält dies für nicht hinnehmbar.

Er begrüßt, dass das BMG die Erhöhung der Mindestreserve des Gesundheitsfonds prüfen will. Er befürwortet zudem die Zusage des BMG, die Anhebung der Höhe der Mindestrücklage und der Obergrenze der Finanzreserven zu untersuchen. Er wiederholt seine Erwartung, dass unterjährige Zusatzbeitragssatzanhebungen die Ausnahme sein sollten. (Textnummern 6, 7)

0.7

Der Bundesrechnungshof empfiehlt, ausgabenseitig Maßnahmen zu ergreifen, die kurzfristig die finanzielle Situation der GKV stabilisieren. Ausgabendämpfende Regelungen, die zuletzt abgeschafft worden waren, sollten wieder eingeführt werden. Die Entkopplung von Vergütungssteigerungen an die Grundlohnrate, die Ist-Kosten-Finanzierung von Pflegepersonalkosten und die Entbudgetierung von Teilen der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung müssen darum kritisch hinterfragt werden.

Wirksame Strukturreformen dürfen nicht länger aufgeschoben werden. Dies gilt in besonderer Weise für die Krankenhausreform. Deren zentrale Elemente, die auf Effizienzsteigerungen, eine Verlagerung hin zur ambulanten Versorgung und Qualitätsverbesserung abzielen, dürfen nicht verwässert werden. Als verfehlt betrachtet der Bundesrechnungshof aktuelle Planungen, Krankenhäusern 4 Mrd. Euro im Wege eines pauschalen Abrechnungszuschlags auszusahlen, um „eine Lücke bei den Sofort-Transformationskosten für die Jahre 2022 und 2023“ zu schließen. Förderungen nach dem Gießkannenprinzip verzögern den Reformprozess. Lediglich bedarfsnotwendige Krankenhäuser sollten einen Ausgleich erhalten.

Möglichkeiten zur Begrenzung der Arzneimittelausgaben hat kürzlich der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege (SVR) aufgezeigt. Er rät, insbesondere die Erstattungsbedingungen innovativer und hochpreisiger Arzneimittel in den Blick zu nehmen und Arzneimittelpreise stärker an den patientenrelevanten Mehrwert zu koppeln. Die Notfall- und Akutversorgung ist ein wesentlicher Bestandteil einer leistungsfähigen Gesundheitsversorgung, deren Reform zu Einsparungen führen kann. (Textnummern 6, 7)

1 Vorbemerkung

Der Bundesrechnungshof prüft in einem mehrjährigen Prüfungsschwerpunkt die Resilienz der staatlichen Kernfunktionen und ihrer kritischen Infrastruktur, insbesondere in den Sektoren Verkehr, Energie, Cybersicherheit, Kommunikation, innere- und äußere Sicherheit, Katastrophen- und Zivilschutz, Gesundheit, Wasser, Ernährung und Finanzen.

Resilienz versteht der Bundesrechnungshof insoweit umfassend als die Fähigkeit, staatliche Kernfunktionen und ihre kritische Infrastruktur zu schützen und einen funktionseinschränkenden Vorfall zu verhindern (präventive Komponente) sowie ursachenunabhängig im Falle eines funktionseinschränkenden Vorfalls auf diesen angemessen zu reagieren, diesen abzuwehren, seine negativen Folgen zu begrenzen sowie die Funktionsfähigkeit der betroffenen staatlichen Kernfunktionen und ihrer Infrastruktur möglichst zügig und umfassend wiederherzustellen (reaktive Komponente).

Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag stieg im Jahr 2025 um knapp anderthalb Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 42,3 %. Allein die GKV verzeichnete einen Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes um 0,8 Prozentpunkte.¹ Die Bundesregierung der 19. Legislaturperiode hatte sich zu dem Ziel bekannt, die Sozialversicherungsbeiträge bis zum Jahr 2021 auf maximal 40 % begrenzen zu wollen (sog. Sozialgarantie 2021).² Im Zuge dessen wurden wiederholt Maßnahmen ergriffen. Auch in der 20. Legislaturperiode unternahm der Gesetzgeber Anstrengungen, insbesondere zur Stabilisierung der Zusatzbeitragssätze. Diese zeigten kurzfristig Erfolge, entfalteten jedoch keine nachhaltige Wirkung. Die Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen³ unterschritten zum Jahresende 2024 die Mindestrücklage. Maßgeblich dafür sind strukturelle Probleme, die auch künftig steigende Zusatzbeitragssätze erwarten lassen. Im Jahr 2024 erhöhten 34 Krankenkassen unterjährig ihre Zusatzbeitragssätze, um ihre Leistungsfähigkeit zu sichern.⁴

Die Beitragseinnahmen der Krankenkassen fließen zunächst in den Gesundheitsfonds. Aus dem Gesundheitsfonds erhalten Krankenkassen Zuweisungen zur Deckung ihrer Ausgaben. Zur Sicherung der Liquidität hält der Gesundheitsfonds eine Reserve vor. Diese war bereits im Mai 2025 derart gefährdet, dass teilweise der Bundeszuschuss aus der Dezemberrate vorzeitig ausgezahlt werden musste.

Der Bundesrechnungshof hat die Entwicklung der Finanzlage der GKV untersucht. Dabei hat er insbesondere die künftige finanzielle Entwicklung, die gesetzlich festgelegte Untergrenze der Liquiditätsreserve und die Mindestrücklage der Finanzreserven

¹ Für die GKV ist der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz von 2,5 % berücksichtigt. Die kassenindividuellen Zusatzbeitragssätze liegen im Durchschnitt über 2,9 %.

² Koalitionsausschuss der 19. Legislaturperiode, Eckpunktepapier Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken vom 3. Juni 2020.

³ Im Folgenden Krankenkassen genannt.

⁴ Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), Datentabelle, Stand: 1. November 2024.

betrachtet. Angesichts der finanziellen Dimensionen und ihrer Auswirkungen auf die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler sowie auf den Bundeshaushalt sieht sich der Bundesrechnungshof veranlasst, dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages über seine Feststellungen zu berichten. Das BMG hat zu den Prüfungsergebnissen des Bundesrechnungshofes Stellung genommen. Die Stellungnahme ist im Bericht berücksichtigt.

2 Thematische Einführung

2.1 Gesundheitsfonds

Die Beitragseinnahmen der Krankenkassen aus dem allgemeinen Beitrag (Satz von derzeit 14,6 %⁵) und den kassenindividuellen Zusatzbeiträgen fließen in den Gesundheitsfonds. Der Gesundheitsfonds ist ein Sondervermögen für die Finanzierung der GKV und wird vom BAS verwaltet. Der Bund zahlt zur pauschalen Abgeltung der Aufwendungen der Krankenkassen für versicherungsfremde Leistungen jährlich 14,5 Mrd. Euro an den Gesundheitsfonds. Dieser Bundeszuschuss wird monatlich zum ersten Bankarbeitstag in Teilbeträgen geleistet.⁶

Der Gesundheitsfonds verteilt Mittel an die Krankenkassen. Die Höhe der Zuweisungen an die einzelnen Krankenkassen richtet sich nach deren Risikostruktur.⁷ Neben einer Grundpauschale pro Person erhalten die Krankenkassen Zu- und Abschläge je nach Alter, Geschlecht sowie Krankheitslast ihrer Versicherten aus dem Gesundheitsfonds. Können Krankenkassen ihren Finanzbedarf aus den Zuweisungen des Gesundheitsfonds nicht decken, müssen sie die entstehende Finanzierungslücke kassenindividuell durch Zusatzbeitragssätze über ihre Mitglieder schließen.

Auf Basis amtlicher Statistiken der GKV prognostiziert der beim BAS angesiedelte sogenannte Schätzerkreis⁸ jährlich Mitte Oktober u. a. die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben des laufenden und des folgenden Jahres. Die Schätzung für das Folgejahr dient als Grundlage, um die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds⁹ an die Krankenkassen zu fixieren und den sogenannten Einkommensausgleich durchzuführen.¹⁰

⁵ § 241 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V).

⁶ § 221 SGB V.

⁷ Die Berechnung der Höhe der Zuweisung erfolgt im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich.

⁸ Er besteht aus Expertinnen und Experten des BMG, des BAS und des GKV-Spitzenverbandes.

⁹ §§ 266 und 270 SGB V.

¹⁰ § 270a SGB V. Krankenkassen erhalten einen Ausgleich der Einnahmen aus dem einkommensabhängigen Zusatzbeitrag. Er bemisst sich nach der Höhe der Beiträge, die sie erzielen würden, wenn die beitragspflichtigen Einnahmen ihrer Mitglieder dem erwarteten Durchschnitt in der gesetzlichen Krankenversicherung entsprächen (BAS, Zugriff vom 22. April 2025).

Zudem bildet sie die Grundlage zur Berechnung der voraussichtlichen Lücke zwischen den Einnahmen und Ausgaben, die dann durch Zusatzbeiträge geschlossen werden muss. Hierfür legt das BMG einen sogenannten durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz der GKV fest.¹¹ Krankenkassen orientieren sich bei der Festsetzung ihrer kassenindividuellen Zusatzbeitragssätze¹² am durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz.

Prognostiziert der Schätzerkreis beispielsweise die Ausgaben der GKV für das folgende Jahr zu niedrig, wird der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz zu niedrig angesetzt. Infolgedessen erheben Krankenkassen tendenziell zu niedrige kassenindividuelle Zusatzbeiträge. In diesem Fall sinken die Finanzreserven der Krankenkassen.¹³

Die Einnahmen des Gesundheitsfonds sind abhängig von der konjunkturellen Entwicklung. Prognostiziert der Schätzerkreis etwa die Einnahmen des Gesundheitsfonds zu hoch, verzeichnet der Gesundheitsfonds durch die fixierten Zuweisungen an die Krankenkassen ein Defizit. Dieses Defizit wird aus der Liquiditätsreserve finanziert, die dadurch sinkt (vgl. Abbildung 1).¹⁴

¹¹ § 242a SGB V.

¹² § 242 Absatz 1 SGB V.

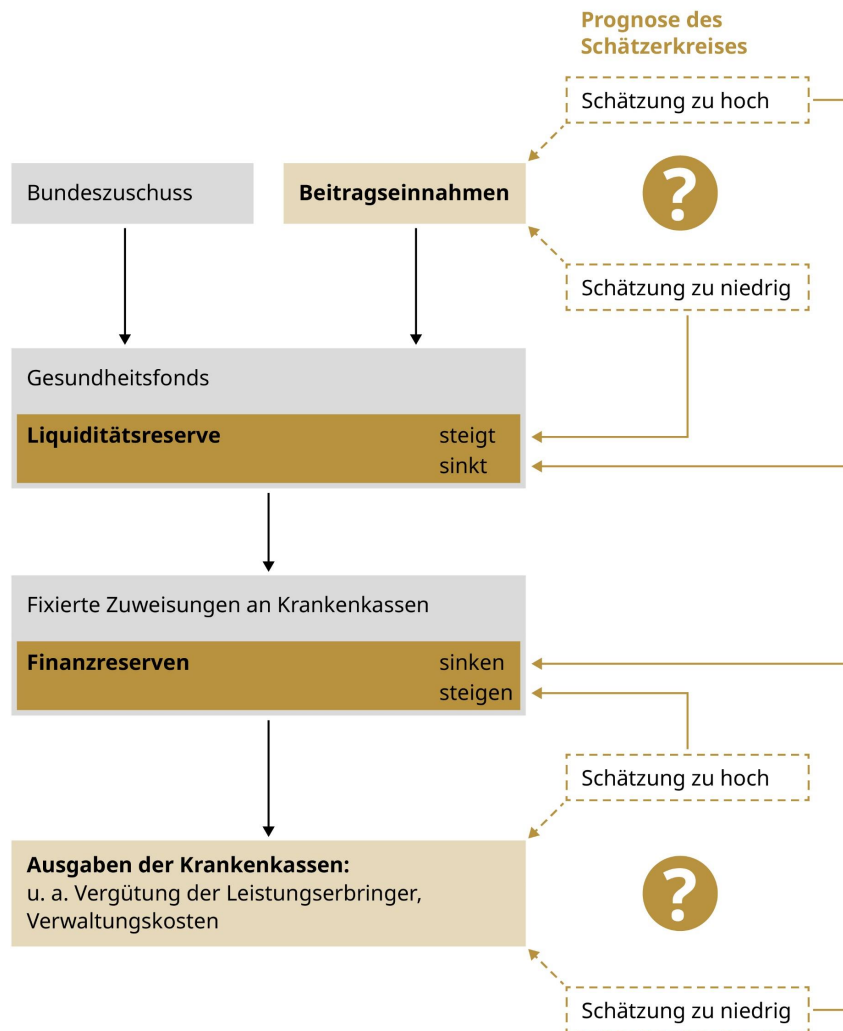
¹³ Vgl. Textnummer 2.4.

¹⁴ Vgl. Textnummer 2.3.

Abbildung 1

Prognose des Schätzerkreises beeinflusst die liquiden Mittel

Die Prognose des Schätzerkreises im Oktober des Vorjahres beeinflusst die Höhe der Finanzreserven der Krankenkassen und die Höhe der Liquiditätsreserve.



Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: SGB V.

2.2 Zusatzbeitragssatz

Krankenkassen haben einen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag als Prozentsatz der beitragspflichtigen Einnahmen jedes Mitglieds zu erheben. Der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz ist so zu bemessen, dass die Zusatzbeitragseinnahmen zusammen mit den Zuweisungen und den sonstigen Einnahmen die im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und die vorgeschriebene Höhe der Rücklage decken.¹⁵

¹⁵ § 242 Absatz 1 SGB V.

Zusatzbeitragssätze werden auf Basis eines vorab aufzustellenden Haushaltsplanes berechnet. Ergibt sich während des Haushaltsjahres, dass die Betriebsmittel der Krankenkassen einschließlich der Zuführung aus der Rücklage zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen, ist der Zusatzbeitragssatz zu erhöhen.¹⁶ Für unvorhersehbare Ausgaben sind Finanzreserven zu bilden, deren Höhe gesetzlich geregelt ist.¹⁷ Dadurch sollen unterjährige Beitragssatzanhebungen vermieden werden.

2.3 Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds

Der Gesundheitsfonds hat liquide Mittel als Liquiditätsreserve vorzuhalten. Die Liquiditätsreserve soll unterjährige Schwankungen der Einnahmen sowie Einnahmeausfälle aufgrund des Einkommensausgleichs ausgleichen.¹⁸

Die Höhe der Liquiditätsreserve muss mindestens 20 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe des Gesundheitsfonds betragen (Mindestreserve). Grundsätzlich darf die Höhe der Liquiditätsreserve einen Betrag von 25 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe nicht überschreiten. Überschreitet die erwartete Höhe der Liquiditätsreserve auf Basis der Prognose des Schätzerkreises die maximal zulässige Höhe, sind die überschüssigen Mittel in die Einnahmen des Gesundheitsfonds zu überführen.¹⁹

In den Jahren 2025 bis 2034 beträgt die maximale Höhe der Liquiditätsreserve 50 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe. Damit wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass – nach geltender Rechtslage – der zur Modernisierung der Krankenhausstruktur einzurichtende Transformationsfonds²⁰ hälftig aus der Liquiditätsreserve finanziert werden soll.²¹ Nicht abgerufene Mittel aus dem Transformationsfonds können in das nächste Geschäftsjahr übertragen werden.²² Überschüssige Mittel sollen somit im Gesundheitsfonds verbleiben und für die Zahlungen an den Transformationsfonds angespart werden.²³

Der Bund leistet ein nicht zu verzinsendes Liquiditätsdarlehen, wenn die Liquiditätsreserve nicht ausreicht, um alle Zuweisungen zu erfüllen. Das Darlehen ist im jeweils

¹⁶ § 242 Absatz 2 SGB V.

¹⁷ Vgl. vertiefend Textnummer 2.4.

¹⁸ § 271 Absatz 2 SGB V i. V. m. § 270a SGB V.

¹⁹ § 271 Absatz 2 SGB V.

²⁰ § 12b Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG). Zur Umsetzung der durch das Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen (Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz – KHVVG) vom 5. Dezember 2024 (BGBl. I Nummer 400) beschlossenen Regeln wird beim BAS ein Transformationsfonds errichtet. Aus dem Transformationsfonds können etwa Vorhaben zur standortübergreifenden Konzentration akutstationärer Versorgungskapazitäten oder Vorhaben zur Umstrukturierung eines Krankenhausstandortes gefördert werden (Krankenhausreform).

²¹ § 271 Absatz 2 SGB V.

²² § 271 Absatz 6 SGB V.

²³ Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen (KHVVG) vom 17. Juni 2024 ([Bundestagsdrucksache 20/11854](#)).

laufenden Haushaltsjahr zurückzuzahlen.²⁴ Die Höhe des Liquiditätsdarlehens war im Jahr 2024 auf 4 Mrd. Euro begrenzt.²⁵

2.4 Finanzreserven der Krankenkassen

Die von den Krankenkassen vorzuhaltenden Finanzreserven umfassen Betriebsmittel, eine als notwendig erachtete Rücklage sowie die Mittel zur Anschaffung und Erneuerung von Verwaltungsvermögen. Rücklagen haben Krankenkassen zur Sicherstellung ihrer Leistungsfähigkeit zu bilden. Das Rücklagesoll wird in der Satzung der Krankenkasse festgelegt und muss mindestens 20 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe betragen (Mindestrücklage).²⁶ Die Mindestrücklage wurde im Jahr 2020 abgesenkt. Bis Ende März 2020 betrug sie noch 25 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe.²⁷

Finanzreserven dürfen im Durchschnitt des Haushaltsjahres 50 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe nicht übersteigen (Obergrenze). Die zuständige Aufsichtsbehörde kann eine höhere Obergrenze für Krankenkassen mit weniger als 50 000 Mitgliedern zulassen.²⁸ Die Obergrenze der Finanzreserve wurde schrittweise abgesenkt. Bis 15. Dezember 2018 durften die Finanzreserven 150 % einer Monatsausgabe, bis 25. November 2020 100 % einer Monatsausgabe und bis 11. November 2022 80 % einer Monatsausgabe nicht übersteigen.²⁹ Finanzreserven, die den gesetzlich festgelegten Maximalbetrag überschreiten, sind innerhalb von zwei Haushaltsjahren durch Absenkung des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes abzuschmelzen. Im ersten Haushaltsjahr hat die Minderung mindestens die Hälfte der übersteigenden Mittel zu betragen.³⁰ Übersteigen die Finanzreserven nach Ablauf der Frist 50 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe oder die von der zuständigen Aufsichtsbehörde zugelassene Obergrenze, hat die Krankenkasse den übersteigenden Betrag an den Gesundheitsfonds abzuführen.³¹

²⁴ § 271 Absatz 3 SGB V.

²⁵ § 11 Absatz 4 Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024 (Haushaltsgesetz 2024 – HG 2024, BGBl. I. Nummer 38). Für das Jahr 2025 ist eine entsprechende Regelung vorgesehen.

²⁶ § 261 Absatz 2 SGB V. Geändert mit dem Gesetz für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung (Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz – GKV-FKG) vom 23. März 2020 (BGBl. I. S. 604).

²⁷ § 261 SGB V alte Fassung.

²⁸ § 260 Absatz 2 SGB V.

²⁹ § 260 Absatz 2 SGB V alte Fassungen.

³⁰ § 260 Absatz 2a SGB V. Die zuständige Aufsichtsbehörde kann die Frist um bis zu zwei Haushaltsjahre verlängern, wenn die übersteigenden Mittel nicht durch einen Verzicht auf die Erhebung eines Zusatzbeitrags abgebaut werden können.

³¹ § 260 Absatz 4 SGB V.

3 Finanzielle Entwicklung der GKV

3.1 Stabilisierung des Zusatzbeitragssatzes

3.1.1 Maßnahmen seit dem Jahr 2020

Der Gesetzgeber beschloss seit dem Jahr 2020 wiederholt Maßnahmen zur Stabilisierung der Zusatzbeitragssätze:

- Im Jahr 2020 erhielt der Gesundheitsfonds für konjunkturbedingte Mindereinnahmen und zur Kompensation aus der Liquiditätsreserve finanzierter pandemiebedingter Maßnahmen einen zusätzlichen Bundeszuschuss von 3,5 Mrd. Euro.³² Dieser Zuschuss trat zu dem jährlichen Zuschuss zur pauschalen Abgeltung versicherungsfremder Leistungen von 14,5 Mrd. Euro hinzu.
- Im Jahr 2021 leistete der Bund erneut einen zusätzlichen Bundeszuschuss von 5 Mrd. Euro, der den Zuschuss für versicherungsfremde Leistungen ergänzte.³³ Des Weiteren hatten Krankenkassen dem Gesundheitsfonds Teile ihrer Finanzreserven zuzuführen. Krankenkassen, deren Finanzreserven mehr als 40 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe betrugen, mussten 66,1 % der darüberhinausgehenden Finanzreserven abführen.³⁴ Dies führte zu einer Vermögensabgabe von 8 Mrd. Euro.³⁵
- Im Jahr 2022 leistete der Bund erneut einen zusätzlichen Bundeszuschuss von 14 Mrd. Euro.³⁶ Damit betrug der Bundeszuschuss insgesamt 28,5 Mrd. Euro. Zudem waren über die Mindestreserve hinausgehende Mittel der Liquiditätsreserve den Einnahmen des Gesundheitsfonds zuzuführen.³⁷ In der Folge wurden die Zuweisungen an die Krankenkassen um 1,5 Mrd. Euro erhöht.³⁸

³² Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020) vom 14. Juli 2020 (BGBl. I. S. 1669).

³³ § 221a Absatz 1 SGB V. Zudem wurden aus der Liquiditätsreserve von 2021 bis 2023 finanzielle Mittel gemäß § 271 Absatz 4 SGB V den Zuweisungen an die Krankenkassen zugeführt. Damit sollten Belastungen aus dem Gesetz zur Einführung eines Freibetrages in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge (GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz – GKV-BRG) vom 30. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2913) abgefedert werden.

³⁴ § 272 Absatz 1 SGB V. Für kleine Krankenkassen galt eine Sonderregelung.

³⁵ Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz – GPVG) vom 19. Oktober 2020 ([Bundestagsdrucksache 19/23483](#)); Schätztableau des Schätzerkreises vom 13. Oktober 2022.

³⁶ § 221a Absatz 3 SGB V in Verbindung mit der Verordnung zur Festsetzung des ergänzenden Bundeszuschusses nach § 221 a Absatz 3 Satz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch für das Jahr 2022 (Bundeszuschussverordnung 2022), Bundesanzeiger AT vom 19. November 2021. Die Höhe des ergänzenden Bundeszuschusses wurde so bemessen, dass der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz bei 1,3 % lag (§ 221a Absatz 3 SGB V).

³⁷ § 272a SGB V.

³⁸ Schätztableau des Schätzerkreises vom 13. Oktober 2022.

Ende des Jahres 2022 ergriff der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz)³⁹ Maßnahmen, die den durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz auf 1,6 % im Jahr 2023 stabilisierten. Dazu hatten Krankenkassen erneut Mittel aus ihren Finanzreserven⁴⁰ dem Gesundheitsfonds zuzuführen: Krankenkassen mussten 40 % der Finanzreserven, die über 20 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe lagen, und 60 % der Finanzreserven, die über 30 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe lagen, dem Gesundheitsfonds zuführen.⁴¹ Die dadurch bewirkte Vermögensabgabe umfasste im Ergebnis 2,5 Mrd. Euro.⁴² Des Weiteren beschloss der Gesetzgeber,

- den Bundeszuschuss um 2 Mrd. Euro zu erhöhen,⁴³
- die maximal zulässige Höhe der Liquiditätsreserve zu senken und übersteigende Mittel von 4,7 Mrd. Euro über die Zuweisungen an die Krankenkassen auszuschütten,⁴⁴
- ein unverzinsliches, im Jahr 2026 zurückzahlendes Bundesdarlehen von 1 Mrd. Euro zu gewähren sowie
- verschiedene, teilweise befristete Anpassungen in den Leistungsbereichen Krankenhaus⁴⁵, Arzneimittel⁴⁶ und vertragsärztliche Versorgung⁴⁷.

Derzeit ist geplant, dass die Rückzahlung des Darlehens nicht bereits zum Jahresende 2026, sondern erst im Jahr 2033 fällig wird.

Im Jahr 2024 wurden zusätzlich 2,7 Mrd. Euro aus der Liquiditätsreserve an die Krankenkassen ausgezahlt, da über die maximale Höhe der Liquiditätsreserve hinausgehende Mittel in die Einnahmen des Gesundheitsfonds überführt werden.⁴⁸

³⁹ Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) vom 9. November 2022 (BGBl. I S. 1990); siehe auch [BMG](#), Zugriff vom 10. April 2025.

⁴⁰ Bei der Berechnung wurden die Finanzreserven nach § 260 Absatz 2 SGB V abzüglich 4 Mio. Euro herangezogen.

⁴¹ § 272b Absatz 1 SGB V. Vom satzungsmäßig festgelegten Rücklagesoll wurden 4 Mio. Euro abgezogen. Für die Berechnung waren die von den Krankenkassen für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegten endgültigen Rechnungsergebnisse heranzuziehen.

⁴² Schätztableau des Schätzerkreises vom 15. Oktober 2024.

⁴³ § 221a Absatz 5 SGB V. Des Weiteren leistete der Bund einen Bundeszuschuss von 2021 bis 2023 als Beitrag zum Ausgleich für die Mehrausgaben in Folge der pandemiebedingten Regelung zum Kinderkrankengeld.

⁴⁴ Im Jahr 2023 wurden aus der Liquiditätsreserve weitere 0,7 Mrd. Euro über die Zuweisungen an die Krankenkassen zugeführt. Davon dienten 0,4 Mrd. Euro als Ausgleich für Zahlungen an Krankenhäuser, denen zusätzliche Mittel für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen bereitgestellt wurden. Mindereinnahmen der Krankenkassen aufgrund des GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz wurden im Jahr 2023 mit 0,3 Mrd. Euro aus der Liquiditätsreserve ausgeglichen.

⁴⁵ Ab dem Jahr 2025 werden im Pflegebudget nur noch die Kosten für qualifizierte Pflegekräfte berücksichtigt.

⁴⁶ Der Herstellerabschlag wurde für das Jahr 2023 um 5 Prozentpunkte erhöht, insbesondere für patentgeschützte Arzneimittel. Der Apothekenabschlag wurde von 1,77 Euro auf 2 Euro auf zwei Jahre befristet erhöht. Strukturelle Änderungen der Preisbildung von neuen Arzneimitteln sollten greifen, die keinen oder nur einen geringen Zusatznutzen haben. Zudem wurden ergänzende Maßnahmen ergriffen, die den Ausgabenanstieg patentgeschützter Arzneimittel dämpfen.

⁴⁷ Die extrabudgetäre Vergütung von vertragsärztlichen Leistungen für Neupatientinnen und Patienten wurde abgeschafft. Zudem wurden Vergütungsanreize für schnellere ärztliche Behandlungstermine eingeführt und der Honorarzuwachs für Zahnärztinnen und Zahnärzte begrenzt.

⁴⁸ Schätztableau des Schätzerkreises vom 15. Oktober 2024. Weitere 0,4 Mrd. Euro wurden der Liquiditätsreserve für den Ausgleich für Zahlungen an Krankenhäuser für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen entnommen.

3.1.2 Empfehlungen des BMG zur weiteren Stabilisierung

Der Gesetzgeber trug dem BMG im November 2022 auf, bis 31. Mai 2023 Empfehlungen für eine stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der GKV zu erarbeiten. Insbesondere sollte die Ausgabenseite betrachtet werden.⁴⁹ Das BMG versandte die Empfehlungen am 10. Januar 2024 an die Bundesministerien. Es führte darin aus, dass mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz verbliebene Effizienzreserven bei den Leistungserbringern gehoben worden seien. Weitere Kostendämpfungsmaßnahmen würden die bereits erkennbaren Versorgungsprobleme und den Fachkräftemangel verschärfen. Dies schmälere die Attraktivität der Gesundheitsberufe und gefährde die Qualität des deutschen Gesundheitswesens.

Vor diesem Hintergrund sei die Einnahmenseite dauerhaft zu stärken. Dazu solle der Bundeszuschuss dynamisiert und dauerhaft erhöht werden. Nicht kostendeckende Beiträge des Bundes für Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger sollten angehoben werden. Würde der gesetzliche Mindestlohn als Bemessungsgrundlage herangezogen, müssten die Beitragszahlungen des Bundes 10 Mrd. Euro höher ausfallen. Angesichts der angespannten Haushaltslage sei dies bislang nicht umgesetzt worden. Sobald es haushaltspolitisch möglich sei, solle das nachgeholt werden.

Auf der Ausgabenseite seien verschiedene Strukturreformen in Angriff genommen, um mittel- bis langfristig die Effizienz und die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern und Kosten zu reduzieren. Es seien verschiedene Reformen beschlossen worden oder geplant, wie die Krankenhausreform, die Notfallreform, die Digitalisierung des Gesundheitswesens, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz und das Gesetzgebungsvorhaben zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hierdurch würden Mittel effizienter eingesetzt und die GKV entlastet. Weitere Einsparmöglichkeiten sah das BMG in der Streichung homöopathischer und anthroposophischer Leistungen sowie in der Begrenzung der Verwaltungskosten der Krankenkassen durch einen geringeren Aufbau von Altersrückstellungen.⁵⁰

Zur Vorbereitung der Empfehlungen hatte das BMG frühzeitig Workshops durchgeführt sowie einnahmen- und ausgabenseitige Optionen zur Stärkung der Finanzen diskutiert. Eine Vorlage bzw. Veröffentlichung der Empfehlungen im Mai 2023 hatte es seinerzeit als zu spät bewertet. Um die finanzielle Situation im Jahr 2024 zu stabilisieren und zeitnah gesetzliche Änderungen anzustoßen, sollte eine Veröffentlichung bereits im März 2023 erfolgen. Dies erwies sich jedoch als nicht umsetzbar.

Vor Versand der Empfehlungen versuchte das BMG, Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) herzustellen. Das BMF kritisierte im Oktober 2023, die Empfehlungen des BMG würden den gesetzlichen Anforderungen nicht vollumfänglich

⁴⁹ § 220 Absatz 4 Satz 1 bis 3 SGB V geändert durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz.

⁵⁰ Empfehlungen des BMG für eine stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 220 Absatz 4 SGB V vom 31. Mai 2023, übermittelt am 10. Januar 2024.

gerecht. Insbesondere für das Jahr 2024 seien nur einmalig wirkende Maßnahmen vorgesehen. Es fehlten Vorschläge zur strukturellen Dämpfung der Ausgaben. Überwiegend würden Einnahmeverbesserungen zulasten des Bundeshaushalts empfohlen. Deutschland hätte im europäischen Vergleich pro Kopf die höchsten Ausgaben für Arzneimittel und eine hohe Zahl von Arztkontakten. Gemessen an der Bettenzahl sei die Krankenhausversorgung deutlich umfänglicher als im europäischen Durchschnitt. Ambulant behandelbare Erkrankungen würden überdurchschnittlich häufig im Krankenhaus behandelt. Gleichzeitig läge die Lebenserwartung in Deutschland nur knapp über dem europäischen Durchschnitt. Die strukturelle Deckungslücke zwischen Einnahmen und Ausgaben bestehe fort. Daraus resultiere das Risiko für eine Belastung der Versicherten und Arbeitgeber. Effizienzsteigerungen im Gesundheitswesen sollten über strukturelle Reformen erschlossen werden, die zur Ausgabenbegrenzung und Qualitätsverbesserung beitragen können. Strukturelle Reformen seien auch mit dem Ziel der Verbesserung der Tragfähigkeit zu verbinden.

Im März 2024 kritisierte das BMF, dass dem BMG ein schlüssiges Gesamtkonzept zur systematischen Stabilisierung der defizitären Dynamik fehle. Das BMG wies dies zurück. Die geplanten weitreichenden Strukturreformen seien auf der Ausgabenseite mittel- bis langfristig der zentrale Schlüssel für eine Stabilisierung der Finanzen. Durch effizientere und bedarfsgerechtere Versorgungsstrukturen sowie mehr Prävention würden mittel- bis langfristig teils erhebliche Einsparungen generiert. Vereinzelt seien zunächst zusätzliche Investitionen notwendig.

3.2 Entwicklung der Liquiditätsreserve

Die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds betrug zum Ende des Auszahlungsjahres 2024 5,7 Mrd. Euro. Zum Ende des Auszahlungsjahres 2025 ist eine Mindestreserve von 4,9 Mrd. Euro vorzuhalten. Folgende Faktoren haben Einfluss auf die unterjährige Entwicklung der Liquiditätsreserve:

- Während die Einnahmen des Gesundheitsfonds unterjährig schwanken, erhalten Krankenkassen ihre vorab fixierten Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds in monatlich gleichen Teilbeträgen. Der Gesundheitsfonds verzeichnet üblicherweise unterjährig ein Defizit, das aufgrund von Jahressonderzahlungen wie dem Weihnachtsgeld zum Jahresende ausgeglichen wird.⁵¹ In den Jahren 2017 bis 2023 sanken die liquiden Mittel unterjährig⁵² um 3,1 bis 4,5 Mrd. Euro. Durchschnittlich betrug der Rückgang 3,7 Mrd. Euro.⁵³
- Der Gesundheitsfonds trägt das Einnahmerisiko aufgrund unerwarteter konjunktureller Einbrüche, die sich durch geringere beitragspflichtige Einnahmen auszeichnen.

⁵¹ BMG, Pressemitteilung, Finanzentwicklung der GKV im 1. bis 3. Quartal 2024 vom 6. Dezember 2024.

⁵² Das Auszahlungsjahr des Gesundheitsfonds beginnt am 16. Januar und endet am 15. Januar des folgenden Jahres. Die Auszahlungsmonate beginnen jeweils am 16. Kalendertag eines Monats. Es werden die übertragenen Mittel aus dem Vormonat und Rückflüsse aus Termingeldern abgebildet.

⁵³ Werte aus dem Jahr 2020 werden aufgrund der pandemiebedingten Abweichungen nicht berücksichtigt.

Werden im Schätzerkreis die erwarteten Einnahmen zu hoch angesetzt, soll die Liquiditätsreserve die Mindereinnahmen ausgleichen. In den Jahren 2017 bis 2023 setzte der Schätzerkreis nur im Pandemiejahr 2020 die Einnahmen zu hoch an.⁵⁴

- Sofern Krankenkassen mit überwiegend einkommensschwächeren Mitgliedern überdurchschnittlich hohe Zusatzbeitragssätze und Krankenkassen mit überwiegend einkommensstärkeren Mitgliedern unterdurchschnittliche Zusatzbeitragssätze erheben, entsteht durch den Einkommensausgleich ein Defizit. Dieses betrug im Jahr 2024 0,8 Mrd. Euro.
- Zusatzbeitragssatzerhöhungen werden von der Rentenversicherung erst mit einer Verzögerung von zwei Monaten bei den Beiträgen zur Krankenversicherung der Rentner berücksichtigt. Insbesondere in Jahren mit deutlichen Zusatzbeitragssatzanhebungen wird dadurch die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds belastet. Dieser Nachlauf führte im Jahr 2024 zu einer Belastung der Liquiditätsreserve von etwa 0,2 Mrd. Euro. Der GKV-Spitzenverband beziffert die Belastung im Jahr 2025 auf 0,7 Mrd. Euro.

Zur Förderung der Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung wurden bzw. werden dem Strukturfonds⁵⁵ in den Jahren 2019 bis 2025 Mittel von bis zu 2 Mrd. Euro aus der Liquiditätsreserve zugeführt. Im Jahr 2025 sind davon noch 1,2 Mrd. Euro von den Ländern abrufbar. Zusätzlich werden liquide Mittel zur Finanzierung des Innovationsfonds von jährlich 0,1 Mrd. Euro aus der Liquiditätsreserve entnommen.⁵⁶

Die beschriebenen Effekte gefährden derzeit die Liquiditätssituation des Gesundheitsfonds. Im Mai 2025 wurde darum die Auszahlung des Bundeszuschusses aus der Dezzemberrate in Höhe von 0,8 Mrd. Euro vorgezogen.

Die Liquidität des Gesundheitsfonds verschärfen würde zudem die derzeitige Regelung, nach der der Transformationsfonds⁵⁷ in den Jahren 2026 bis 2035 mit jährlich 2,5 Mrd. Euro aus der Liquiditätsreserve finanziert werden soll (vgl. Textnummer 2.3). Im Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode „Verantwortung für Deutschland“ ist allerdings geplant, den für die GKV vorgesehenen Anteil von 25 Mrd. Euro aus dem neu bereitgestellten Sondervermögen Infrastruktur und damit aus Bundesmitteln zu finanzieren.⁵⁸ In den Jahren 2026 bis 2029 plant der Bund zudem die Länder zu entlasten und einen Finanzierungsanteil von 3,5 Mrd. Euro pro Jahr zu leisten. Die Länder zahlen in diesem Zeitraum 1,5 Mrd. Euro pro Jahr.⁵⁹

⁵⁴ Schätzerkreis, Schätztableaus der Jahre 2015 bis 2024.

⁵⁵ § 271 Absatz 6 SGB V; Strukturfonds nach § 12a KHG i. V. m. § 221 Absatz 2 SGB V.

⁵⁶ § 271 Absatz 5 SGB V.

⁵⁷ § 12b KHG.

⁵⁸ Koalitionsvertrag, S. 108.

⁵⁹ Beschlusspapier der Bund-Länder-AG vom 23. Juni 2025.

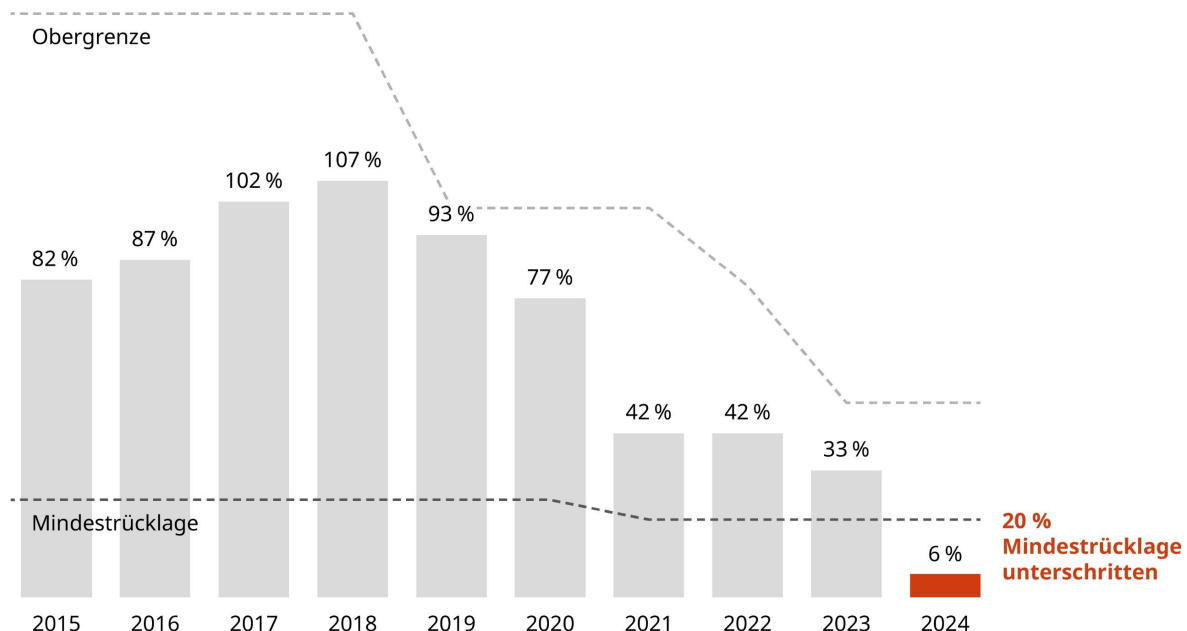
3.3 Entwicklung der Finanzreserven

Die Finanzreserven der Krankenkassen sanken seit dem Jahr 2018 deutlich. Ende des Jahres 2024 betragen sie 6 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe (vgl. Abbildung 2).⁶⁰

Abbildung 2

Finanzreserven der Krankenkassen sinken unter Mindestrücklage

Die Finanzreserven der Krankenkassen schmolzen in den vergangenen Jahren kontinuierlich ab und lagen zum Jahresende 2024 deutlich unter der Mindestrücklage von 20 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe.



Quelle: Endgültige GKV-Rechnungsergebnisse für die Jahre 2015 bis 2024.

Die Obergrenze der Finanzreserven wurde schrittweise abgesenkt. Die Absenkung von 150 % auf 100 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe ab dem Jahr 2019 begründete das BMG mit der Anpassung an aktuelle Strukturen. Seit Einführung des Gesundheitsfonds sei das Einnahmerisiko von Krankenkassen auf den Gesundheitsfonds übergegangen, der somit das Risiko für unerwartete konjunkturelle Einbrüche vollständig trage. Die gesetzliche Obergrenze sei so bemessen, dass sie hinreichenden Spielraum

⁶⁰ Die Höhe der Mindestreserve ergibt sich aus der Haushaltsplanung der Krankenkassen. Wird diese der Berechnung zugrunde gelegt, ergibt sich eine geringfügig niedrigere Mindestreserve.

für notwendige Investitionen bei gleichzeitiger Absicherung der Leistungsausgaben belasse.⁶¹

Die Absenkung der Obergrenze auf 80 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe für das Jahr 2022 sollte Krankenkassen motivieren, Finanzreserven abzubauen sowie stabilere oder niedrigere Zusatzbeitragssätze zu erheben. Die Höhe hielt das BMG für angemessen, da die verbleibende Obergrenze dem Vierfachen der gesetzlichen Mindestrücklage entspräche.⁶²

Mit einer weiteren Absenkung der Obergrenze auf 50 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe ab dem Jahr 2023 sollten die Krankenkassen veranlasst werden, ihre Finanzmittel einzusetzen, um ihre Zusatzbeiträge zu stabilisieren. Die neue Obergrenze entspräche dem 2,5-fachen der gesetzlichen Mindestrücklage.⁶³ Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens hatte das Fachreferat des BMG darauf hingewiesen, dass das finanzielle Risiko für Krankenkassen, für die GKV als Haftungssystem und für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler durch das erhebliche Abschmelzen der Reserven und die gleichzeitige Absenkung der Obergrenze erhöht werde. Unterjährige Anhebungen des Zusatzbeitragssatzes würden dadurch wahrscheinlicher.

Die Absenkung der gesetzlichen Mindestrücklage im Jahr 2020 von 25 % auf 20 % einer Monatsausgabe wurde ebenfalls mit dem Übergang des Einnahmerisikos auf den Gesundheitsfonds begründet. Eine Mindestrücklage von 25 % einer Monatsausgabe entspräche nicht mehr dem tatsächlichen Mindestbedarf, um die Leistungsfähigkeit der Krankenkassen sicherzustellen. Durch die Absenkung erhielten Krankenkassen größere Handlungsspielräume bei ihrer Haushaltsplanung.⁶⁴

Die Mindestrücklage aller Krankenkassen lag Ende des Jahres 2024 bei 5,5 Mrd. Euro. Der GKV-Spitzenverband hielt den finanziellen Spielraum zum Ausgleich von Einnahmen- und Ausgabenschwankungen im Jahr 2024 infolge der Absenkung der Obergrenze für nicht mehr ausreichend. Unterjährig hoben 34 Krankenkassen ihre Zusatzbeitragssätze an, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Sechs davon mussten unterjährig sogar zweimal ihre Zusatzbeitragssätze anpassen. Über 60 % der Krankenkassen, die unterjährig ihren Zusatzbeitragssatz anheben mussten, verfügten Ende des Jahres 2023 über Finanzreserven von über 20 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe.

Der Schätzerkreis prognostizierte im Oktober 2024 einen Ausgabenanstieg für das Jahr 2025 von 6,8 %.⁶⁵ Im 1. Quartal 2025 verzeichneten Krankenkassen einen Anstieg

⁶¹ Entwurf eines Gesetzes für bessere und unabhängige Prüfungen (MDK-Reformgesetz) vom 23. September 2019 ([Bundestagsdrucksache 19/13397](#), S. 60).

⁶² Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz – GPVG) vom 19. Oktober 2020 ([Bundestagsdrucksache 19/23483](#), S. 35).

⁶³ Entwurf des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes vom 19. September 2022 ([Bundestagsdrucksache 20/3448](#), S. 49).

⁶⁴ Entwurf eines Gesetzes für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 12. Februar 2020 ([Bundestagsdrucksache 19/17155](#), S. 132).

⁶⁵ [Schätztableau des Schätzerkreises vom 15. Oktober 2024](#).

von 7,8 %.⁶⁶ Bis 1. Juli 2025 erhöhten 15 Krankenkassen erneut die Zusatzbeitragssätze. Weitere unterjährige Anhebungen sind nicht ausgeschlossen.

Regelmäßig erzielten einzelne Krankenkassen Rechnungsergebnisse, die zu einem Abschmelzen der Finanzreserven von über 30 % führen. So wiesen im Jahr 2015 14 Krankenkassen (11 % der Krankenkassen), im Jahr 2019 neun Krankenkassen (8 % der Krankenkassen) und im Jahr 2020 elf Krankenkassen (10 % der Krankenkassen) ein Defizit von über 30 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe aus.

3.4 Rechnungsergebnis der Krankenkassen im Jahr 2024

Krankenkassen verzeichneten im Jahr 2024 ein Defizit von 6,6 Mrd. Euro, das insbesondere auf gestiegene Leistungsausgaben zurückzuführen ist. Mit 8,2 % stiegen die Leistungsausgaben gegenüber dem Vorjahr stärker als in jedem anderem Jahr der vergangenen drei Jahrzehnte. Das mittlere jährliche Wachstum lag in den Jahren 2010 bis 2023 bei 4,4 %.

Überdurchschnittliche Ausgabensteigerungen verzeichneten Krankenkassen etwa im stationären Sektor. Für Krankenhausbehandlungen verausgabten sie 102,2 Mrd. Euro, dies entspricht einer Steigerung von 8,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Ebenfalls überdurchschnittlich wuchsen die Ausgaben für Arzneimittel. Mit einer Veränderungsrate von 9,9 % wuchsen die Ausgaben für Arzneimittel auf 55,2 Mrd. Euro. Die Aufwendungen für ambulante ärztliche Behandlungen stiegen mit 6,7 % auf insgesamt 50,3 Mrd. Euro. Ausgaben für Fahrkosten stiegen ebenfalls überdurchschnittlich mit 10 % auf 9,6 Mrd. Euro.⁶⁷

Das BMG hielt die Preiskomponente in vielen Ausgabenbereichen für ursächlich. Der Gesetzgeber habe in den letzten 10 bis 15 Jahren vielfach ausgabendämpfende Regelungen eingeschränkt oder zurückgenommen. Dazu gehört vor allem die Entkopplung der Vergütungssteigerungen von der Grundlohnrate,⁶⁸ die Übernahme der Ist-Kosten-

⁶⁶ BMG, Pressemitteilung, vorläufige GKV-Rechnungsergebnisse für das Jahr 2025 vom 20. Juni 2025.

⁶⁷ GKV-Spitzenverband, GKV-Kennzahlen mit Stand von Juni 2025.

⁶⁸ Im stationären Bereich gilt als Obergrenze für die Veränderung von Landesbasisfallwerten seit dem Jahr 2013 nicht mehr die Grundlohnrate, sondern der Veränderungswert nach § 9 Absatz 1b KHEntgG. Die tatsächliche Kostenentwicklung der Krankenhäuser ermittelt das Statistische Bundesamt jährlich und berechnet daraus einen Orientierungswert. Die Grundlohn- bzw. Veränderungsrate nach § 71 Absatz 3 SGB V gibt die Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen an. Ist der Orientierungswert geringer als die Veränderungsrate, entspricht der Veränderungswert dieser Veränderungsrate. Ist der Orientierungswert höher als die Veränderungsrate, vereinbaren die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Verband der Privaten Krankenversicherung und der GKV-Spitzenverband den Veränderungswert (siehe auch BMG). So lag der Veränderungswert in den Jahren 2022 bis 2024 über der Grundlohnrate (vgl. AOK-Bundesverband). Mit dem KHVVG weitete der Gesetzgeber den Verhandlungsspielraum für die Vertragspartner aus, so dass künftig höhere Veränderungswerte zulässig sind.

Finanzierung durch die Krankenkassen beim Pflegepersonal⁶⁹ und die Entbudgetierung⁷⁰ von Hausärztinnen und Hausärzten. Überproportionale Ausgabenzuwächse seien insbesondere bei patentgeschützten Arzneimitteln zu verzeichnen. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz habe die finanzielle Situation nur vorübergehend stabilisiert. Zusätzliche Bundesmittel, das Abschmelzen der GKV-Reserven und der einmalig erhöhte Arzneimittel-Herstellerrabatt wirkten nur vorübergehend. Reformen im Rahmen des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes führten – nach interner Einschätzung des BMG – nicht zu den erhofften Einsparungen.

3.5 Künftige Entwicklung

Zukünftig stehen den ständig steigenden Ausgaben geringere Zuwächse der Einnahmen gegenüber, die aufgrund der demographischen und konjunkturellen Entwicklung erwartet werden. Allein deswegen wachsen die Ausgaben jährlich um 6 bis 8 Mrd. Euro stärker als die Einnahmen. Dies hätte einen Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes von 0,3 Beitragssatzpunkten pro Jahr zur Folge.⁷¹

Zusätzlich bewirken kürzlich beschlossene Gesetze einen massiven Ausgabenanstieg in der GKV für die kommenden Jahre. Im Februar 2025 beschloss der Gesetzgeber etwa die Entbudgetierung der Hausärztinnen und Hausärzte. Leistungen der allgemeinen hausärztlichen Versorgung einschließlich der erbrachten Hausbesuche sind ab dem 1. Oktober 2025 mit den Preisen der regionalen Euro-Gebührenordnung vollständig zu vergüten.⁷²

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz liegt im Jahr 2025 bei 2,5 %.⁷³ Er ist damit seit dem Jahr 2015 von 0,9 % um 1,6 Beitragssatzpunkte angestiegen (vgl. Abbildung 3). Das BMG rechnete in einer Prognose (sog. Mittelfristmodell) im Frühjahr 2025 für die mittelfristige Finanzentwicklung in der GKV mit einem weiter steigenden durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz. Bis zum Jahr 2029 schätzt es in einem mittleren Szenario einen Anstieg auf 4,05 %.⁷⁴ Kassenindividuelle Zusatzbeitragssätze können vom

⁶⁹ Die vollständige Ist-Kosten-Finanzierung von Pflegepersonalkosten durch die Kostenträger (Kranken- und Pflegekosten) wurde durch das Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (Pflegepersonal-Stärkungsgesetz – PpSG) vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I 2018 S. 2394) eingeführt. Vor der Einführung dieses Finanzierungsmodells wurden die Personalkosten für Pflegeleistungen aus den Fallpauschalen gezahlt. Dabei bestand ein Anreiz, dass Pflegepersonal möglichst „günstig“ beschäftigt wurde, weil höhere Kosten nicht automatisch refinanziert wurden.

⁷⁰ Bei der Entbudgetierung fallen Leistungen nicht mehr unter die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung, die budgetiert ist. Eine mengenmäßige Begrenzung entfällt und Leistungen werden vollständig und unabhängig von Obergrenzen gezahlt. Für die hausärztliche Versorgung erfolgte die Entbudgetierung durch das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Kommune (Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz – GVSG) vom 25. Februar 2025 (BGBl. I. Nummer 64).

⁷¹ Prognose des BMG aus dem Frühjahr 2025 mit Stand vom 13. März 2025.

⁷² GVSG vom 25. Februar 2025 (BGBl. I. Nummer 64). Im Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode „Verantwortung für Deutschland“ ist vorgesehen, eine Entbudgetierung von Fachärztinnen und Fachärzten in unterversorgten Gebieten zu prüfen (vgl. [Koalitionsvertrag](#), S. 106).

⁷³ [Bundesanzeiger](#), Bekanntmachung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes nach § 242a Absatz 2 SGB V für das Jahr 2025.

⁷⁴ Prognose des BMG aus dem Frühjahr 2025 mit Stand vom 13. März 2025.

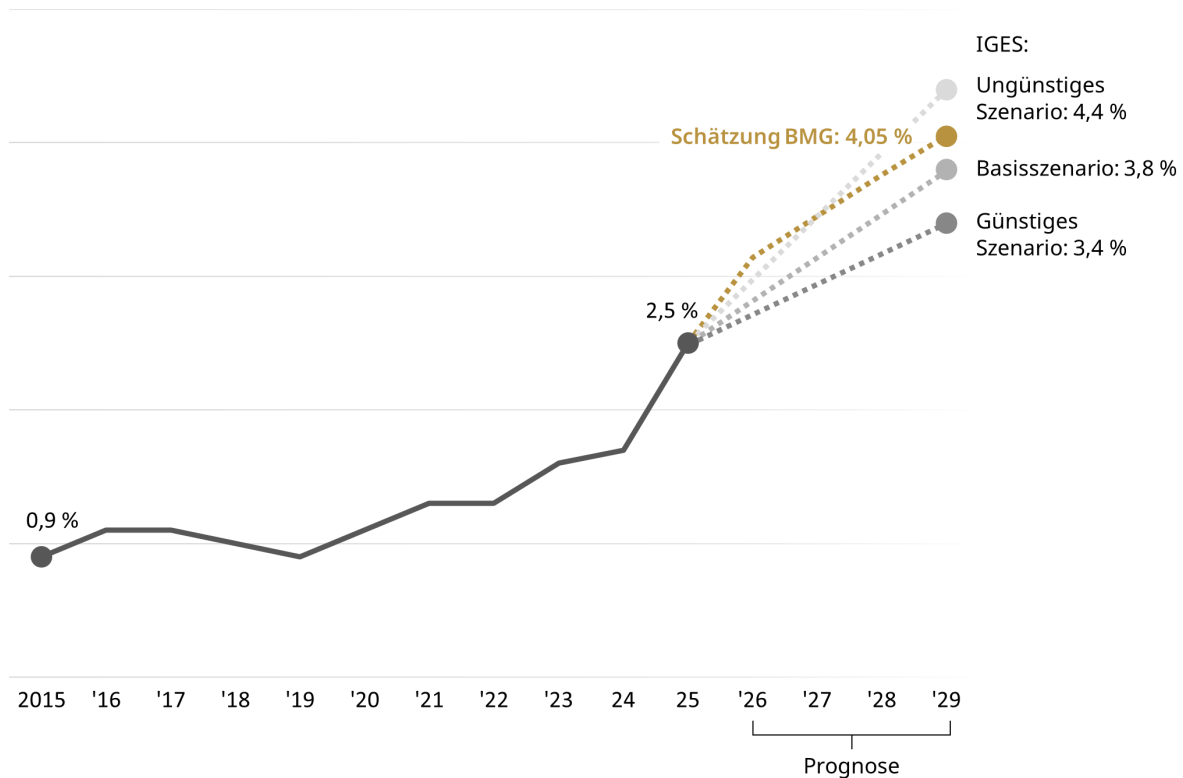
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz abweichen, wenn etwa andere Einnahmen- oder Ausgabensteigerungen erwartet werden.

Ein wissenschaftliches Institut befasste sich im Juni 2025 mit der Entwicklung des Zusatzbeitragssatzes. Im Falle einer günstigen Entwicklung prognostizierte es einen Zusatzbeitragssatz von 3,4 % im Jahr 2029, in einem Basisszenario von 3,8 % und bei einer ungünstigen Entwicklung von 4,4 %. Bis zum Jahr 2035 könnten die Zusatzbeitragssätze im günstigsten Fall auf 3,4 %, im Basisszenario auf 5,4 % und im ungünstigsten Szenario auf 8,0 % steigen.⁷⁵

Abbildung 3

Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz steigt deutlich

Das BMG schätzt bis zum Jahr 2029 einen Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes auf 4,05 %. Ein wissenschaftliches Institut prognostiziert einen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz zwischen 3,4 % und 4,4 % im Jahr 2029.



Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: Bundesanzeiger; Prognose des BMG aus dem Frühjahr 2025 mit Stand vom 13. März 2025. IGES-Institut, Beitragssatzentwicklung in der Sozialversicherung vom 26. Juni 2025.

⁷⁵ IGES-Institut, Beitragssatzentwicklung in der Sozialversicherung vom 26. Juni 2025, S. 11.

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz berücksichtigt nicht die für den Aufbau von Reserven benötigten Mittel. Bundesunmittelbare Krankenkassen⁷⁶ haben laut BAS im Jahr 2025 ihre Zusatzbeitragssätze so berechnet, dass ein Aufbau der Finanzreserven um insgesamt 3,3 Mrd. Euro geplant ist. Dies entspricht 0,29 Zusatzbeitragssatzpunkten. Einige Krankenkassen erheben Zusatzbeiträge in einer Höhe, die zum Aufbau von Finanzreserven über dem gesetzlichen Minimum führen. Zum 1. Januar 2025 haben 82 Krankenkassen ihre Beitragssätze erhöht, bei 11 Krankenkassen ist der Zusatzbeitragssatz unverändert geblieben, da zum Teil bereits im Jahresverlauf 2024 Anhebungen erfolgten.⁷⁷ Im Durchschnitt lagen die kassenindividuellen Zusatzbeitragssätze Anfang 2025 bei 2,92 % und damit deutlich über dem vom BMG bekanntgegebenen Zusatzbeitragssatz. Kassenindividuell variierte der Zusatzbeitragssatz zwischen 2,18 und 4,4 %.⁷⁸

Die Regierungskoalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode „Verantwortung für Deutschland“ das Ziel gesetzt, die Finanzsituation in der GKV zu stabilisieren und eine weitere Belastung für die Beitragszahlerinnen und -zahler zu vermeiden. Strukturelle Anpassungen und kurzfristige Maßnahmen sollen umgesetzt werden, um die seit Jahren steigende Ausgabendynamik zu stoppen und die strukturelle Lücke zwischen Ausgaben und Einnahmen zu schließen. Um die Beiträge der GKV-Mitglieder langfristig stabilisieren zu können, sollen die Einnahmen durch ein höheres Beschäftigungsniveau vergrößert und die Kosten auf der Ausgabenseite reduziert werden. Dafür soll eine Kommission unter Beteiligung von Expertinnen und Experten und Sozialpartnern eingerichtet werden. Die gesundheitspolitischen Vorhaben des Koalitionsvertrags sollen in der Gesamtwirkung betrachtet werden. Bis zum Frühjahr 2027 sollen Ableitungen getroffen und konkrete weitere Maßnahmen vorgeschlagen werden.⁷⁹

4 Vorläufige Würdigung

4.1 Stabilisierung der GKV ist unabdingbar

Der Bundesrechnungshof hat die finanzielle Situation der GKV als kritisch bewertet. Eine jährlich um 6 bis 8 Mrd. Euro wachsende strukturelle Lücke belastet

⁷⁶ Bundesunmittelbare Krankenkassen sind solche, deren Zuständigkeitsbereich sich über mehr als drei Bundesländer erstreckt. Zu den landesunmittelbaren Krankenkassen gehören die Allgemeinen Ortskrankenkassen und einige Innungs- sowie Betriebskrankenkassen.

⁷⁷ BMG, Pressemitteilung, vorläufige GKV-Rechnungsergebnisse für das Jahr 2024 vom 7. März 2025.

⁷⁸ GKV-Spitzenverband, Krankenkassenliste, Zugriff vom 2. Juli 2025. Es wurden nur geöffnete Krankenkassen betrachtet.

⁷⁹ Vgl. Koalitionsvertrag, S. 105.

Beitragszahlerinnen und Beitragszahler sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Diese Entwicklung ist nicht allein auf äußere Faktoren wie den technischen Fortschritt und die demographische Entwicklung zurückzuführen. Insbesondere führte die Abschaffung bzw. Beschränkung kostendämpfender Regelungen zur Erhöhung der strukturellen Deckungslücke. Diese wird künftig noch durch geringere Einnahmen aufgrund der alternden Bevölkerung verstärkt.

Das BMG hat versäumt, frühzeitig Maßnahmen zur Stabilisierung der finanziellen Situation zu ergreifen. Viele der mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz im Jahr 2022 eingeführten Maßnahmen bewirkten nur einmalige oder kurzfristige Entlastungen. Dies betraf insbesondere die Vermögensabgabe aus den Finanzreserven und den zusätzlichen Bundeszuschuss. Durch Bundesdarlehen wird das finanzielle Problem lediglich zeitlich verlagert.⁸⁰

Im Jahr 2022 verpflichtete der Gesetzgeber das BMG, Vorschläge für eine stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der GKV zu erarbeiten und dabei insbesondere die Ausgabenseite zu betrachten. Die Empfehlungen legte das BMG mehr als sieben Monate zu spät vor. Auch dadurch unterblieb eine kurzfristige Stabilisierung. Inhaltlich blieben die Empfehlungen weit hinter den Erwartungen zurück. Die geplanten Struktur-reformen, die mittel- bis langfristig wirken sollten, waren nicht mit konkreten Einsparzielen hinterlegt. Die Notfallreform wurde bis heute nicht umgesetzt. Kurzfristige Einsparmöglichkeiten wie etwa die Streichung homöopathischer und anthroposophischer Leistungen sowie bei den Verwaltungskosten der Krankenkassen hätten die strukturelle Deckungslücke nicht annähernd schließen können. Die – ebenfalls nicht eingeführte – Dynamisierung des Bundeszuschusses und der Beiträge für Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger hätten zwar einnahmeseitig kurzfristig die finanzielle Situation entlasten können. Langfristig hätte aber auch dies keine ausreichende Wirkung. Bei einer um jährlich 6 bis 8 Mrd. Euro steigenden Deckungslücke würden zusätzliche Beiträge für Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger von 10 Mrd. Euro die finanzielle Situation allenfalls ein bis zwei Jahre festigen. Eine Stabilisierung über die Dynamisierung des Bundeszuschusses würde zu einer steigenden Belastung des Bundeshaushaltes führen. In zehn Jahren müsste der Bundeszuschuss 60 bis 80 Mrd. Euro umfassen.

Das BMG hat die Chance vertan, frühzeitig auf die Beitragssatzentwicklung zu reagieren. Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, ausgabenseitig Maßnahmen zu ergreifen, die kurzfristig die finanzielle Situation stabilisieren. Kurzfristig könnten ausgabendämpfende Regelungen wieder eingeführt werden, wie etwa die Kopplung von Vergütungssteigerungen an die Grundlohnrate, die Abschaffung der Ist-Kosten-

⁸⁰ Vgl. Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages Information über die Entwicklung des Einzelplans 15 für die Beratungen zum Bundeshaushalt 2023 vom 7. September 2022 (Gz.: IX 1 - 0001176) und Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages Information über die Entwicklung des Einzelplans 15 (BMG) für die Beratungen zum Bundeshaushalt 2025 vom 3. Juli 2025 (Gz.: IX 1 - 0002661).

Finanzierung von Pflegepersonalkosten und die Wiedereinführung der Budgetierung von Teilen der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung.

4.2 Mindestreserve des Gesundheitsfonds ist zu niedrig

Der Bundesrechnungshof hat zwar die im Koalitionsvertrag vereinbarte Zielsetzung befürwortet, die Finanzsituation und damit die Beiträge zur GKV langfristig zu stabilisieren. Er hat aber das Fehlen konkreter finanzwirksamer Maßnahmen bedauert. Verfehlt ist es insbesondere, erst in zwei Jahren mögliche Strategien vorzustellen. Der Bundesrechnungshof hat die Höhe der Mindestreserve als zu niedrig bemessen erachtet. Der notwendige Zahlungsfluss der Zuweisungen an die Krankenkassen wird hierdurch gefährdet. Die Liquiditätsreserve muss unterjährige Einnahmeschwankungen, Effekte aus dem Einkommensausgleich sowie Mindereinnahmen bei Zusatzbeitragssatzerhöhungen ausgleichen. Allein unterjährige Schwankungen können zu einem saisonalen Defizit von bis zu 4,5 Mrd. Euro führen. Falls der Schätzerkreis unvorhergesehene Mindereinnahmen aufgrund einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Situation nicht ausreichend berücksichtigt, kann der Gesundheitsfonds ein massives Defizit verzeichnen. Eine Mindestreserve von nur 20 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe entspricht im Jahr 2025 4,9 Mrd. Euro. Der Bundesrechnungshof hat Zweifel geäußert, ob dies ausreicht, um die genannten Effekte zuverlässig abzusichern. Diese Sorge wird erhärtet durch das Vorziehen des Bundeszuschusses von 0,8 Mrd. Euro. Der Bundesrechnungshof hat darum empfohlen, die Mindestreserve der Liquiditätsreserve prozentual zu erhöhen.

4.3 Mindestrücklagen der Krankenkassen zu gering bemessen

Der Bundesrechnungshof hat auch die von den Krankenkassen vorzuhaltende Mindestrücklage von mindestens 20 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe für zu niedrig gehalten. Die Finanzreserven der Krankenkassen sollen auch bei unvorhersehbaren Ausgabenschwankungen unterjährige Zusatzbeitragssatzerhöhungen vermeiden helfen. Dies ist bei der gegenwärtigen Höhe nicht gewährleistet. Über 60 % der Krankenkassen, die im Jahr 2024 ihren Zusatzbeitragssatz unterjährig anheben mussten, verfügten zum Jahresende 2023 noch über Finanzreserven oberhalb der Mindestrücklage. Bis 1. Juli 2025 erhöhten weitere 15 Krankenkassen unterjährig ihre Zusatzbeitragsätze. Über ein gesamtes Haushaltsjahr geltende, konstante Zusatzbeitragsätze sollten die Regel und unterjährige Beitragssatzanhebungen eine Ausnahme sein. Dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis ist durch die geltende Mindesthöhe der Finanzreserven nicht mehr sichergestellt.

Die Mindestrücklage wurde abgesenkt, um Reserven abzubauen und die finanzielle Situation der GKV zu stabilisieren. Mit dieser Zweckentfremdung der Finanzreserve wurde genau das Gegenteil erreicht und die Stabilität der unterjährigen Zusatzbeiträge gefährdet. Das Einnahmerisiko ist zwar auf den Gesundheitsfonds übergegangen. Das Risiko von Ausgabensteigerungen – und diese sind derzeit in besonderer Weise zu verzeichnen – muss jedoch nach wie vor von den Krankenkassen ausgeglichen werden. Prognosen können derart von der tatsächlichen Entwicklung abweichen, dass die Finanzreserven nicht ausreichen. Dies zeigte die Entwicklung im vergangenen Jahr. Trotz unterjähriger Zusatzbeitragssatzanhebungen hatten Krankenkassen 2024 ein Defizit von 6,6 Mrd. Euro zu verzeichnen. Die Mindestrücklage aller Krankenkassen beispielsweise lag dagegen Ende des Jahres 2024 bei nur 5,5 Mrd. Euro.

Die Bemessung der Finanzreserven muss Krankenkassen einen hinreichenden Spielraum für Investitionen erlauben und gleichzeitig die Leistungsausgaben absichern. Bei dem derzeit geltenden Abstand von nur 30 Prozentpunkten zwischen Mindestrücklage und Obergrenze ist dies nicht sichergestellt. Die regelhafte Geltungsdauer der Zusatzbeiträge von einem Jahr darf nicht durch zu geringe Finanzreserven vereitelt werden. Der Bundesrechnungshof hat dem BMG empfohlen, die Höhe der Mindestrücklage und der Obergrenze der Finanzreserve zu analysieren und so anzuheben, dass künftig unterjährige Beitragssatzerhöhungen weitgehend vermieden werden.

5 Stellungnahme des BMG

5.1 Mittel- bis langfristige Finanzprognosen sind unsicher

Das BMG hat darauf hingewiesen, dass mittel- bis langfristige Finanzprognosen in der GKV in hohem Maße von unterstellten Annahmen abhängig und mit erheblicher Unsicherheit behaftet seien. Dies gelte neben der demografischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung insbesondere auch für die Ausgabenentwicklung in der GKV. Diese sei – im Unterschied zu anderen Sozialversicherungszweigen – abhängig von einer Vielzahl Angebots- und nachfrageseitiger Faktoren in vielen sehr unterschiedlich regulierten Leistungsbereichen mit teils hochkomplexen Vergütungssystemen. Die Folgen gesetzgeberischer Maßnahmen – insbesondere bei Strukturreformen wie der Krankenhausreform – seien angesichts des Zusammenspiels von gesetzlichen Anreizwirkungen und Verhaltensreaktionen der betroffenen Akteure häufig nur schwer vorherzusagen. Auch die Wirkungen des medizinisch-technischen Fortschritts sowie die jährlichen Vergütungsvereinbarungen zwischen Krankenkassen, Leistungserbringern und deren Organisationen auf verschiedenen Verhandlungsebenen und in verschiedenen

Leistungsbereichen sowie die Richtlinien und Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Konkretisierung des Leistungsumfangs hätten einen großen und kaum vorhersagbaren Einfluss auf die Ausgabenentwicklung.

Aus diesen Gründen habe der Gesetzgeber ausdrücklich dem Schätzerkreis nach § 220 Absatz 2 SGB V die gesetzliche Aufgabe zugewiesen, jedes Jahr bis 15. Oktober die Ausgaben und Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung lediglich für das laufende und das kommende Jahr auf Basis dann vorliegender aktuellster Erkenntnisse und Daten zu prognostizieren. Auf Basis dieser Prognose ermittle das BMG den durchschnittlichen ausgabendeckenden Zusatzbeitragssatz für das nächste Jahr.

5.2 Finanzstabilisierung im Koalitionsvertrag vereinbart

Der Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode sehe vor, die Finanzsituation der GKV zu stabilisieren und eine weitere Belastung für die Beitragszahlerinnen und -zahler zu vermeiden. Dazu solle ein Gesamtpaket aus strukturellen Anpassungen und kurzfristigen Maßnahmen beschlossen werden. Eine Kommission unter Beteiligung von Expertinnen und Experten und Sozialpartnern solle konkrete Maßnahmen zur langfristigen Stabilisierung der Beiträge erarbeiten und bis Frühjahr 2027 – ggf. schon früher – vorlegen.

5.3 Gesetzliche Anpassungen werden geprüft

Das BMG hat die Zweifel geteilt, dass die Höhe der gesetzlichen Mindestreserve des Gesundheitsfonds von 0,2 Monatsausgaben nicht ausreichen könnte, um unterjährige Einnahmeschwankungen und mögliche weitere Belastungen zuverlässig abzusichern. Darum werde es eine Erhöhung der Mindestreserve prüfen.

Über ein gesamtes Haushaltsjahr geltende, konstante Zusatzbeitragssätze sollten zwar die Regel und unterjährige Beitragssatzanhebungen die Ausnahme sein. Dass der Abstand von 30 Prozentpunkten zwischen Mindestrücklage und Obergrenze zu gering sei, teile das BMG aber nur eingeschränkt. Der gegenwärtige Abstand erlaube einen hinreichenden Spielraum für Investitionen und sichere gleichzeitig die Leistungsausgaben. Die Spanne von 0,3 Monatsausgaben entspräche ca. 0,45 Zusatzbeitragssatzpunkten. Krankenkassen könnten während ihrer Haushaltsplanungen für die Bemessung ihrer Finanzreserven zwischen Mindestrücklage und Obergrenze über einen Spielraum von durchschnittlich 0,45 Zusatzbeitragssatzpunkten verfügen. Im Jahr 2024 seien dies rund 8 Mrd. Euro.

Die Ausgaben habe der Schätzerkreis nur in drei der letzten zehn Jahre zwischen 2014 und 2023 unterschätzt. Die maximale Unterschätzung hätte bei 2,9 Mrd. Euro gelegen, im Mittel beliefe sich die Unterschätzung auf ca. 1,5 Mrd. Euro. Weitaus häufiger habe

der Schätzerkreis die Ausgaben – um durchschnittlich 1,8 Mrd. Euro – überschätzt. Die maximale Überschätzung habe 3,5 Mrd. Euro umfasst. Vor diesem Hintergrund seien auch die zeitweise hohen Finanzreserven von GKV – weit über 20 Mrd. Euro bzw. mehr als eine Monatsausgabe – entstanden. Die erhebliche Unterschätzung des Schätzerkreises für die Ausgaben im Jahr 2024 um ca. 7,6 Mrd. Euro sei einzigartig und auf die Auswirkungen der hohen Inflation zurückzuführen. Diese seien in diesem Umfang nicht vorhergesehen worden. Dies erkläre auch die flächendeckenden unterjährigen Anhebungen der Zusatzbeitragssätze im vergangenen Jahr.

Das BMG werde die Anhebung der Höhe der Mindestrücklage und der Obergrenze der Finanzreserven prüfen.

6 Abschließende Würdigung

6.1 GKV-Finzen stehen massiv unter Druck

Die GKV-Finzen stehen massiv unter Druck. Das BMG selbst geht in internen Prognosen von einer jährlich um 6 bis 8 Mrd. Euro steigenden strukturellen Deckungslücke zwischen Beitragseinnahmen und -ausgaben aus. Der Bundesrechnungshof erkennt ausdrücklich an, dass derartige Prognosen stets mit Unsicherheiten behaftet sind. Das BMG ist als verantwortliches Ressort verpflichtet, die Leistungsfähigkeit der GKV sicherzustellen und deren Rahmenbedingungen zu gestalten. Dazu muss es die Finanzsituation der GKV gewissenhaft beobachten. Einvernehmen zwischen BMG und Bundesrechnungshof besteht hinsichtlich der besonderen Dynamik: Die Ausgaben steigen erheblich schneller als die Einnahmen, was zu einer jährlich wachsenden strukturellen Deckungslücke führt. Wissenschaftliche Analysen bestätigen diese Entwicklung.

Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel der Stabilisierung der Finanzsituation der GKV und ihrer Beiträge wird vom Bundesrechnungshof uneingeschränkt begrüßt. Durch die Vorlage der Kommissions-Ergebnisse im Frühjahr 2027 könnten gesetzgeberische Maßnahmen aber realistischerweise erst ab dem Jahr 2028 greifen und Wirkung zeigen. Das strukturelle Defizit würde bis dahin um weitere 12 bis 16 Mrd. Euro anwachsen. Der Bundesrechnungshof hält dies für nicht vertretbar. Unerlässlich ist, neben langfristig notwendigen Strukturreformen auch kurzfristig finanzwirksame Maßnahmen zu ergreifen. Maßnahmen sind mit Einsparzielen zu unterlegen.

6.2 Mindestreserve des Gesundheitsfonds anheben

Der Bundesrechnungshof begrüßt, dass das BMG die Erhöhung der Mindestreserve des Gesundheitsfonds prüfen will. Eine zügige Erhöhung ist notwendig, um künftig unterjährige Liquiditätsdarlehen oder vorgezogene Bundeszuschüsse zu vermeiden. Typische unterjährige Schwankungen der Einnahmen- wie der Ausgabenseite können bereits zu einem saisonalen Defizit von bis zu 4,5 Mrd. Euro führen. Eine nur 20 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe umfassende Mindestreserve (4,9 Mrd. Euro im Jahr 2025) stellt insoweit keine ausreichende Vorsorge dar.

Zur Bemessung einer ausreichenden Mindestreserve des Gesundheitsfonds empfiehlt der Bundesrechnungshof, sämtliche in Betracht kommenden Effekte wie etwa saisonale Schwankungen und unerwartete Mindereinnahmen zu analysieren. Eine Erhöhung der Mindestreserve könnte im Folgejahr zu steigenden Zusatzbeitragssätzen führen. Zur Entschärfung könnte ein schrittweises Auffüllen der Liquiditätsreserve erwogen werden.

6.3 Mindestrücklagen der Krankenkassen und Obergrenzen erhöhen

Den Abstand von 30 Prozentpunkten zwischen Mindestrücklage und Obergrenze bei den Finanzreserven der Krankenkasse hält der Bundesrechnungshof – nach wie vor – für nicht ausreichend bemessen. Es trifft zwar zu, dass Krankenkassen bei ihrer Haushaltsplanung nach den gegenwärtigen Vorschriften ein Spielraum von 0,45 Zusatzbeitragssatzpunkten für Investitionen und die Sicherung der Leistungsausgaben verbleibt. Analysen zeigen jedoch, dass Defizite von über 30 % einer durchschnittlichen Monatsausgabe nicht unüblich sind. Im Jahr 2015 verzeichneten 11 %, im Jahr 2019 8 % und im Jahr 2020 10 % aller Krankenkassen ein Defizit von über 30 %. Die gesetzliche Ausgestaltung der Krankenkassen-Rücklagen erscheint vor diesem Hintergrund nicht ausreichend tragfähig.

Die Ausgabenunterschätzung im Jahr 2024 führte zu einem Defizit von 6,6 Mrd. Euro. Auch im Jahr 2025 zeichnet sich ab, dass die Ausgaben zu niedrig geschätzt wurden. Während der Schätzerkreis noch einen Ausgabenanstieg von 6,8 % prognostizierte, verzeichneten Krankenkassen im 1. Quartal 2025 einen sehr dynamischen Anstieg von 7,8 %. Allein bis zum 1. Juli 2025 hoben 15 Krankenkassen unterjährig den Zusatzbeitragssatz an.

Der Bundesrechnungshof begrüßt, dass das BMG die Anhebung der Höhe der Mindestrücklage und der Obergrenze der Finanzreserven prüfen will. Er wiederholt seine Erwartung, dass unterjährige Zusatzbeitragssatzanhebungen die Ausnahme bilden

sollten. Künftig sollten die Finanzreserven nicht zur kurzfristigen Stabilisierung der GKV-Finzen herangezogen werden.

7 Fazit

Die GKV ist ein wesentlicher Bestandteil des deutschen Gesundheitswesens. Die Stärkung ihrer finanziellen Situation dient der Stabilisierung einer staatlichen Kernfunktion und sichert die Handlungsfähigkeit in künftigen Krisen.

Die Ausgaben der GKV steigen deutlich schneller als die Einnahmen. Das BMG selbst schätzt – unter Berücksichtigung eindeutiger Unsicherheiten – einen durchschnittlichen Zusatzbeitragsatz von über 4 % im Jahr 2029. Durch jährlich steigende Zusatzbeiträge werden Beitragszahlerinnen und Beitragszahler sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber massiv belastet und der wirtschaftliche Aufschwung gefährdet. Bereits jetzt beträgt der Gesamtsozialversicherungsbeitrag über 42 %. Die Sozialgarantie 2021 und die Stabilisierungsmaßnahmen in den folgenden Jahren sollten diesem Umstand entgegenwirken. Ursächlich für den Ausgabenanstieg ist insbesondere die Abschaffung kosten-dämpfender Regelungen. Hinzu kommen der technische Fortschritt und die weitere demographische Entwicklung. Eine alternde Bevölkerung verstärkt die strukturelle Deckungslücke, da – neben ohnehin wachsenden Ausgaben – mit Renteneintritt der Versicherten geringere Einnahmen zu erwarten sind.

Aus Sicht des Bundesrechnungshofes sind ausgabenseitig Maßnahmen zu ergreifen, die kurzfristig die finanzielle Situation der GKV stabilisieren und alle relevanten Leistungsbereiche umfassen, insbesondere solche, in denen aktuell deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind. Wirksame Strukturreformen dürfen nicht länger aufgeschoben werden. Verzögerungen führen zu weiteren, vermeidbaren Ausgaben. Dies gilt in besonderer Weise für die Krankenhausreform. Krankenhausaussgaben bilden den mit Abstand größten Ausgabenblock in der GKV. Zentrale Elemente der Krankenhausreform, die auf Effizienzsteigerungen, eine Verlagerung hin zur ambulanten Versorgung und Qualitätssteigerung abzielen, dürfen darum nicht verwässert werden. Als verfehlt betrachtet der Bundesrechnungshof in diesem Zusammenhang aktuelle Planungen, Krankenhäusern 4 Mrd. Euro auszuzahlen, um „eine Lücke bei den Sofort-Transformationskosten für die Jahre 2022 und 2023“ zu schließen, und dazu einen pauschalen Zuschlag auf Abrechnungen für die Behandlung gesetzlich Versicherter in der Zeit vom 1. November 2025 bis 31. Oktober 2026 zu gewähren. Förderungen nach dem Gießkannenprinzip verzögern den Reformprozess. Lediglich bedarfsnotwendige

Krankenhäuser sollten einen Ausgleich erhalten. Kliniken, deren dauerhaftes Fortbestehen aufgrund der Krankenhausreform fraglich ist, dürfen nicht begünstigt werden.⁸¹

Ausgabendämpfende Regelungen, die zuletzt gestrichen worden waren, sollten wieder eingeführt werden. Die Entkopplung von Vergütungssteigerungen an die Grundlohnrates, die Ist-Kosten-Finanzierung von Pflegepersonalkosten und die Entbudgetierung von Teilen der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung müssen darum kritisch hinterfragt werden.

Zur kurzfristigen Erschließung notwendiger Einsparmaßnahmen empfiehlt der Bundesrechnungshof, an sachkundige Vorschläge anzuknüpfen. So hat der SVR im Mai dieses Jahres Möglichkeiten zur Begrenzung der Arzneimittelausgaben beschrieben. Er rät insbesondere, die Erstattungsbedingungen innovativer und hochpreisiger Arzneimittel in den Blick zu nehmen und Arzneimittelpreise stärker an den patientenrelevanten Mehrwert zu koppeln.⁸²

Die Notfall- und Akutversorgung ist ein wesentlicher Bestandteil einer leistungsfähigen Gesundheitsversorgung, deren Reform zu sinkenden Ausgaben führen kann. Im Bereich der Fahrkosten sind die Kosten der GKV für Rettungsdienstleistungen von den Ausgaben abzugrenzen, die von den Ländern für die im Rahmen der Gefahrenabwehr und Daseinsvorsorge zu tragen sind. Beteiligungsrechte der Krankenkassen, z. B. bei Errichtung neuer Luftrettungsstandorte und anderen bedeutsamen Investitionen, sollten adäquat zu ihrer Finanzierungsverantwortung gestaltet werden.⁸³

Darlehen aus dem Bundeshaushalt müssen mittelfristig zurückgezahlt werden und können die strukturellen Probleme der GKV naturgemäß nicht lösen. Sie verschärfen die Situation vielmehr in der Zukunft: Ein vom Bund im Jahr 2025 geplantes Darlehen von 2,3 Mrd. Euro ist zwischen 2029 und 2033 zurückzuzahlen. Die Rückzahlung des im Jahr 2023 gewährten Darlehens von 1 Mrd. Euro soll von 2026 ins Jahr 2033 verschoben werden. Ob Strukturreformen, die von der Kommission im Jahr 2027 vorgeschlagen werden sollen, bereits im Jahr 2029 zu Einsparungen führen, ist ungewiss. Strukturreformen können kurzfristig zu Ausgabensteigerungen führen. So werden für die Transformation des stationären Sektors zusätzliche Mittel von 50 Mrd. Euro in einem Zeitraum von zehn Jahren benötigt.

Mögliche Strategien erst im Frühjahr 2027 vorzustellen, bewertet der Bundesrechnungshof daher kritisch. Vielmehr ist ein entschlossenes sofortiges Handeln angezeigt. Zur langfristigen Stabilisierung sollte zügig ein Gesamtkonzept erarbeitet und mit

⁸¹ Vgl. Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages Information über die Entwicklung des Einzelplans 15 (BMG) für die Beratungen zum Bundeshaushalt 2025 vom 3. Juli 2025 (Gz.: IX 1 - 0002661).

⁸² Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege, Preise innovativer Arzneimittel in einem lernenden Gesundheitssystem vom 22. Mai 2025.

⁸³ Vgl. Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages über die Finanzierung der Versorgung mit Rettungsfahrten und Flugrettungstransporten vom 20. August 2018 (Gz.: IX 1 - 2017 - 0798).

Einsparzielen unterlegt werden, das couragierte Handeln auf der Einnahmen- wie auf der Ausgabenseite umfasst. Effizienzreserven sind mit strukturellen Reformen zu heben.

Dr. Weber

Sievers

Beglaubigt: Schmid, Tarifbeschäftigte

Wegen elektronischer Bearbeitung ohne Unterschrift und Dienstsiegelabdruck.



Ausschussdrucksache
21(14)11
zur 4. Sitzung vom 10.07.2025

04.08.2025

Bundesministerium für Gesundheit, 11055 Berlin

Vorsitzende
des Ausschusses für Gesundheit
des Deutschen Bundestages
Frau Dr. Tanja Machalet, MdB
11011 Berlin

Tino Sorge
Parlamentarischer Staatssekretär
Mitglied des Deutschen
Bundestages

Mauerstraße 29
10117 Berlin

Postanschrift:
11055 Berlin

Tel. +49 30 18 441-1020
Fax +49 30 18 441-1750

Tino.Sorge@bmg.bund.de

www.bundesgesundheitsministerium.de

Betreff: Nachfrage aus der AfG-Sondersitzung vom 10. Juli 2025

Berlin, 25. Juli 2025
Seite 1 von 2

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

im Rahmen der Sondersitzung des Ausschusses für Gesundheit am 10. Juli 2025 wurde von Herrn MdB Gürpinar (Die Linke) gefragt, ob das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) die Fa. Fiege von Ansprüchen der Bundesregierung freigestellt hat und falls ja, in welcher Form und aus welchem Grund. Die Frage beantworte ich wie folgt:

Im Rahmen der Maßnahmen des Bundes zur Beschaffung von Persönlicher Schutzausrüstung waren Haftungsübernahmen und Forderungsabtretungen als Vertragsklauseln in der Hochphase der Pandemiebekämpfung in Einzelfällen erforderlich, um die den Bund bei der Beschaffung unterstützenden Unternehmen einbinden zu können. Das BMG hat regelmäßig darauf geachtet, dass die Verträge die üblichen Käuferrechte gewährten.

Wesentlicher Sinn und Zweck des sog. Logistikersourcings war es, wie bei der Beschaffung mit Hilfe anderer deutscher Großunternehmen, während der Not-situation in der Pandemie deren Verbindungen nach China zu nutzen, um dortige Einkaufsmöglichkeiten nutzen zu können. Insofern war es üblich, die Verträge mit einem weitgehenden Haftungsausschluss und einer Freistellungsver- einbarung zu verbinden.

Hinweis zu unseren Datenschutzinformationen:

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind in der Datenschutzerklärung des BMG zu finden: www.bundesgesundheitsministerium.de „Stichwort: Datenschutz“ ([Bundesgesundheitsministerium Datenschutz](http://www.bundesgesundheitsministerium.de)). Sollten Sie keinen Internetzugang haben, kann die Information auf dem Postweg zugesandt werden.

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.



Seite 2 von 2

Beim Logistikersourcing sollten im Gegenzug die Ansprüche des Logistikunternehmens gegen den eigenen Verkäufer an den Bund abgetreten werden, so dass der Bund so gestellt werden sollte, als hätte er unmittelbar selbst mit dem jeweiligen ursprünglichen Verkäufer bzw. Hersteller der Masken kontrahiert.

Mit freundlichen Grüßen

Änderungsanträge
der Fraktionen CDU, CSU und SPD
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Befugniserweite-
rung und Entbürokratisierung in der Pflege (Drucksache 21/1511)

Änderungsantrag Nr. 1

Zu Artikel 3 Nummer 15a (§ 73 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

(Vorgaben für die Gestaltung von
PVS-Systemen)

Nach Artikel 3 Nummer 15 wird die folgende Nummer 15a eingefügt:

,15a. Nach § 73 Absatz 10 wird der folgende Absatz 10a eingefügt:

„(10a) Vertragsärzte dürfen für die Verordnung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, von Hilfsmitteln, häuslicher Krankenpflege und außerklinischer Intensivpflege, Soziotherapie sowie spezialisierter ambulanter Palliativversorgung nur solche elektronischen Programme nutzen, die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die vertragsärztliche Versorgung zugelassen sind. Das Nähere zu den fachlichen Anforderungen an die elektronischen Programme kann in den Verträgen nach § 82 Absatz 1 vereinbart werden.“

Begründung:

§ 73 Absatz 9 und 10 SGB V gewährleisten für einzelne veranlasste Leistungen nach § 73 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und 7a SGB V, dass nur solche Software für die Verordnung der dort genannten Leistungen genutzt wird, die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zugelassen wurde und bestimmte Vorgaben erfüllt, die im Bundesmantelvertrag-Ärzte festgehalten sind. Die vorgesehene Regelung schließt eine bisher bestehende Regelungslücke und weitet die Vorgaben auf alle weiteren veranlassten Leistungen aus, die in § 73 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 SGB V genannt werden. Mit der Regelung wird eine Vereinfachung der Verordnungspraxis für die Vertragsärzte erreicht und eine qualitativ hochwertige sowie rechtskonforme Softwarenutzung im Rahmen der Verordnungstätigkeit gewährleistet.

Änderungsantrag Nr. 2

Zu Artikel 3 Nummer 31, 31a und 41 (§§ 291, 291a und 362 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

(Nutzung des Videoident-Verfahrens durch Krankenkassen)

Artikel 3 wird wie folgt geändert:

1. Nummer 31 wird durch die folgende Nummer 31 ersetzt:

„31. § 291 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 7 wird durch den folgenden Absatz 7 ersetzt:

„(7) Die Krankenkassen stellen den Versicherten gemäß den Festlegungen der Gesellschaft für Telematik ein technisches Verfahren barrierefrei zur Verfügung, welches die Anforderungen nach § 336 Absatz 4 erfüllt. Mit Zustimmung des Versicherten sind die Krankenkassen hierbei befugt, zur Prüfung der Identität des Versicherten Daten entsprechend den Vorgaben des § 20 Absatz 3a Satz 1 des Personalausweisgesetzes, des § 16a Absatz 3 Satz 1 des Passgesetzes und des § 78 Absatz 7 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes zu den betroffenen Datenkategorien und deren Verarbeitung auszulesen und zu verwenden; Entsprechendes gilt für das Auslesen und Verwenden von Daten aus einem amtlichen Ausweis oder Pass eines anderen Staates, mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird. Die Krankenkassen stellen den Versicherten gemäß den Festlegungen der Gesellschaft für Telematik ein technisches und automatisiertes Verfahren barrierefrei zur Verfügung, um aus der Komponente nach § 360 Absatz 10 Satz 1 heraus die Nutzung von Verfahren zur Wahrnehmung der Zugriffsrechte nach § 336 Absatz 1 zu beantragen. Die Krankenkassen haben die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Versicherte ein Identifizierungsverfahren spätestens am übernächsten Werktag nach der Beantragung nach Satz 3 nutzen können.“

b) Absatz 8 und 9 wird durch die folgenden Absätze 8 und 9 ersetzt.

„(8) Die Krankenkassen stellen den Versicherten ergänzend zur elektronischen Gesundheitskarte auf Verlangen eine digitale Identität für das Gesundheitswesen barrierefrei zur Verfügung, die die Vorgaben nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 erfüllt und die Bereitstellung von Daten nach § 291a Absatz 2 und 3 durch die Krankenkassen ermöglicht. Mit Zustimmung des Versicherten sind die Krankenkassen hierbei befugt, zur Prüfung der Identität des Versicherten Daten entsprechend den Vorgaben des § 20 Absatz 3a Satz 1 des Personalausweisgesetzes, des § 16a Absatz 3 Satz 1 des Passgesetzes und des § 78 Absatz 7 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes zu den betroffenen Datenkategorien und deren Verarbeitung auszulesen und zu verwenden; Entsprechendes gilt für das Auslesen und Verwenden von Daten aus einem amtlichen Ausweis oder Pass eines anderen Staates, mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird. Ab dem 1. Januar 2027 dient die digitale Identität nach Satz 1 in gleicher Weise wie die elektronische Gesundheitskarte zur Authentisierung des Versicherten im Gesundheitswesen und als Versicherungsnachweis nach § 291a Absatz 1. Die Gesellschaft für Telematik legt die Anforderungen an die Sicherheit und Interoperabilität der digitalen Identitäten fest. Die Festlegung der Anforderungen an die Sicherheit und den Datenschutz erfolgt dabei im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit auf Basis der jeweils gültigen Technischen Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik und unter Berücksichtigung der notwendigen Vertrauensniveaus der unterstützten Anwendungen. Eine digitale Identität kann über verschiedene Ausprägungen mit verschiedenen Sicherheits- und Vertrauensniveaus verfügen. Das Sicherheits- und Vertrauensniveau der Ausprägung einer digitalen Identität muss mindestens dem Schutzbedarf der Anwendung entsprechen, bei der die digitale Identität eingesetzt wird. Abweichend von Satz 7 kann der Versicherte nach umfassender Information durch die Krankenkasse über die Besonderheiten des Verfahrens in die Nutzung einer digitalen Identität einwilligen, die einem

anderen angemessenen Sicherheitsniveau entspricht. Die Anforderungen an die Sicherheit und Interoperabilität dieses Nutzungsweges der digitalen Identität werden von der Gesellschaft für Telematik festgelegt. Die Festlegung erfolgt hinsichtlich der Anforderungen an die Sicherheit und den Datenschutz im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der oder dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Die Krankenkassen sind verpflichtet, berechtigten Dritten die Nutzung der digitalen Identitäten nach Satz 1 zum Zwecke der Authentifizierung von Versicherten zu ermöglichen. Berechtigte Dritte nach Satz 11 sind Anbieter von Anwendungen nach § 306 Absatz 4 oder Anbieter, für die aufgrund eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung die Nutzung der digitalen Identität nach Satz 1 vorgeschrieben ist. Darüber hinaus kann die Gesellschaft für Telematik durch verbindlichen Beschluss nach § 315 Absatz 1 Satz 1 Anbieter weiterer Dienste oder Anwendungen nach § 306 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a als berechtigte Dritte diskriminierungsfrei festlegen. Berechtigte Dritte dürfen zum Zweck der Authentifizierung von Versicherten mittels der digitalen Identitäten personenbezogene Daten des Versicherten verarbeiten, sofern diese für die Nutzung der digitalen Identität erforderlich sind und der Versicherte in die Nutzung der digitalen Identität durch die jeweilige Anwendung eingewilligt hat. Bei der Verarbeitung sind die Anforderungen des Datenschutzes einzuhalten. Die Krankenkassen stellen den zur Nutzung berechtigten Dritten Verfahren zur Erprobung der Integration der digitalen Identität nach Satz 1 zur Verfügung.

(9) Die Versicherten können von ihrer Krankenkasse über eine von ihrer Krankenkasse angebotene Benutzeroberfläche einen Nachweis der Berechtigung zur Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung für die Vorlage bei einem Leistungserbringer anfordern, der unmittelbar von der Krankenkasse über ein sicheres Übermittlungsverfahren nach § 311 Absatz 6 an den Leistungserbringer übermittelt wird. Mit Einwilligung des Versicherten kann ein Leistungserbringer den in Satz 1 genannten Nachweis auch unmittelbar über das sichere Übermittlungsverfahren nach § 311 Absatz 6 anfordern. Der Leistungserbringer hat die Einwilligung des Versicherten zu protokollieren. Voraussetzung für die Nutzung des Verfahrens nach Satz 2 ist, dass der Versicherte in der jeweiligen Leistungserbringerinstitution bekannt ist. Das Verfahren nach den Sätzen 2 bis 4 soll nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Das Weitere zur Durchführung des Verfahrens nach den Sätzen 2 bis 4 regelt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen im Benehmen mit den Verbänden der Leistungserbringer. Für die Mitteilung der durchgeführten Prüfung des Nachweises nach Satz 1 durch den Leistungserbringer gilt § 291b Absatz 3 entsprechend.“ ‘

2. Nach Nummer 31 wird die folgende Nummer 31a eingefügt:

„31a. § 291a Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Ab dem 1. Januar 2027 kann der Versicherungsnachweis auch durch eine digitale Identität nach § 291 Absatz 8 erbracht werden.“ ‘

3. In Artikel 3 Nummer 41 wird in § 362 Absatz 1 Satz 1 die Angabe „§ 291 Absatz 8 Satz 5 bis 9“ durch die Angabe „§ 291 Absatz 8 Satz 6 bis 10“ ersetzt.

Begründung:

Zu Nummer 1

Zu Absatz 7 und 8

Für das Gesundheitswesen durften seit 2022 ausschließlich Identifizierungsverfahren genutzt werden, die eine Prüfung des Ausweises vor Ort beinhalten (z. B. Geschäftsstelle der Krankenkasse oder POSTIDENT Zustellung) sowie Verfahren unter Nutzung der Online-Funktion des Personalausweises. Identifizierungsverfahren mit Videolident-Anteilen bieten für den Gesundheitsbereich grundsätzlich eine weitere Möglichkeit für Versicherte, sich auf einem alternativen Weg zu identifizieren, ohne dass sie ihre PIN zum Ausweis oder zur elektronischen Gesundheitskarte (eGK) benötigen oder dafür in einer Krankenkassen-Geschäftsstelle erscheinen müssen. Die gematik hat nun die sicherheitstechnische Eignung für den Einsatz eines solchen neuen Identifizierungsverfahrens in der Telematikinfrastruktur (TI) bestätigt. Bei diesem Identifizierungsverfahren werden zur zusätzlichen Absicherung

neben Videoident-Anteilen auch Daten aus dem Personalausweis oder dem Pass ausgelesen und genutzt. Dieses Verfahren kann aktuell von den Krankenkassen für die Ausgabe der PIN zur eGK genutzt werden. Die Freigabe des Verfahrens für die Identifizierung zur Einrichtung der GesundheitsID ist in Vorbereitung. Damit zur Prüfung der Identität der Personalausweisinhaberin oder des Personalausweisinhabers, der Passinhaberin oder des Passinhabers die entsprechenden Daten von einer öffentlichen Stelle ausgelesen und bestimmte Daten zum Zwecke der Identitätsüberprüfung verwendet werden dürfen, bedarf es nach dem Passgesetz und nach dem Personalausweisgesetz einer gesetzlichen Befugnis oder einer auf einem Gesetz beruhenden Befugnis. Die Vorschrift schafft ausschließlich die nach § 20 Absatz 3a Satz 1 des PAuswG und § 16a Absatz 3 Satz 1 des PassG erforderliche gesetzliche Befugnis für die Identifizierung bei der Ausgabe der PIN und zur Einrichtung der GesundheitsID. Bei der Verarbeitung der Daten sind die Vorschriften des Personalausweisgesetzes und des Passgesetzes insbesondere § 20 Absatz 3a Satz 2 und 3 des PAuswG und § 16a Absatz 3 Satz 2 und 3 PassG zu beachten.

Die Nutzung der digitalen Identität nach Satz 1 in gleicher Weise wie die eGK zur Authentisierung des Versicherten im Gesundheitswesen und als Versicherungsnachweis nach § 291a Absatz 1 muss aufgrund ausstehender technischer Vorarbeiten angepasst werden.

Zu Absatz 9

Die Regelung entspricht wortgleich dem Gesetzentwurf und muss im Änderungsantrag aus rein redaktionellen Gründen wiederholt werden.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Anpassung des Datums in § 291 Absatz 8.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung eines Satzes in § 291 Absatz 8.

Änderungsantrag Nr. 3

Zu Artikel 3 Nummer 31a (§ 311 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

(Beleihung und Anordnung der
Sofortigen Vollziehbarkeit)

Nach Artikel 3 Nummer 31 wird die folgende Nummer 31a eingefügt:

„31a. Nach § 311 Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Die Aufgaben der Zulassung, der Festlegung und der Bestätigung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bis 6, der Erteilung von Anweisungen nach § 329 Absatz 3 Satz 2 und § 333 Absatz 3, der Beauftragung nach § 385 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und der Zertifizierung nach § 385 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 werden als hoheitliche Aufgaben des Bundes durch die Gesellschaft für Telematik als Beliehene wahrgenommen. Die Zertifizierungsleistungen nach § 385 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 können als hoheitliche Aufgaben des Bundes neben der Gesellschaft für Telematik auch durch akkreditierte Stellen nach § 385 Absatz 7 als Beliehene erbracht werden. Die Wahrnehmung der Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2 schließt die Befugnis zum Erlass von Verwaltungsakten und zu deren Vollstreckung, zur Rücknahme und zum Widerruf der erlassenen Verwaltungsakte sowie zum Erlass der Widerspruchsbescheide ein. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Entscheidungen der Beliehenen haben keine aufschiebende Wirkung. Die Gesellschaft für Telematik und die akkreditierten Stellen nach § 385 Absatz 7 unterliegen bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen hoheitlichen Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2 der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums für Gesundheit.“ ‘

Begründung:

Durch Aufnahme einer ausdrücklichen Beleihungsklausel wird klargestellt, dass die Gesellschaft für Telematik bei der Durchführung von Zulassungs-, Festlegungs-, und Bestätigungsverfahren sowie bei der Erteilung von Anweisungen zur Abwehr von Gefahren für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Telematikinfrastruktur, zur Vermeidung von Störungen nach § 329 Absatz 3 Satz 2 und zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln nach § 333 Absatz 3 sowie bei der Beauftragung nach § 385 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und der Zertifizierung nach § 385 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 hoheitlich handelt. Die Zertifizierungsleistungen nach § 385 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 können als hoheitliche Aufgaben des Bundes neben der Gesellschaft für Telematik auch durch die Stellen nach § 385 Absatz 7 als Beliehene erbracht werden. Sofern die Gesellschaft für Telematik in diesem Umfang als Beliehene tätig wird, unterliegt sie der Rechts- und Fachaufsicht durch das Bundesministerium für Gesundheit. Die Regelung beinhaltet die für die Wahrnehmung der Aufgaben der Gesellschaft für Telematik, für welche sie beliehen wird, erforderliche Befugnis zum Erlass von Verwaltungsakten. Darüber hinaus wird die Befugnis zur Vollstreckung, zur Rücknahme und zum Widerruf der von der Gesellschaft für Telematik erlassenen Verwaltungsakte geregelt. Die Gesellschaft für Telematik kann außerdem Widerspruchsbescheide erlassen. Sämtliche Verwaltungsakte, die die Gesellschaft für Telematik als Beliehene im Rahmen ihrer hoheitlichen Tätigkeit erlässt, sind sofort vollziehbar.

Änderungsantrag Nr. 4

Zu Artikel 3 Nummer 35 (§ 342 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

(Fristverschiebung ePA-Datenausleitung)

In Artikel 3 Nummer 35 Buchstabe a wird in § 342 Absatz 2 Nummer 4 die Angabe „31. März 2026“ durch die Angabe „30. Oktober 2026“ ersetzt.

Begründung:

Es handelt sich bei der Anpassung um eine Verschiebung der gesetzlich festgelegten Frist für die Ausleitung von Daten aus der elektronischen Patientenakte an das Forschungsdatenzentrum Gesundheit. Bereits im Kabinettentwurf ist eine Verschiebung der Frist vorgesehen. Diese Fristverschiebung wird nun nochmals angepasst. Infolge erforderlicher technischer Vorarbeiten und neuer Planungen zu den vorgesehenen Releases im Jahr 2026 ist es erforderlich, dass der Termin angepasst wird. Da die derzeit im Gesetz vorgesehene Frist bereits abgelaufen ist (15. Juli 2025) ist eine zeitnahe Anpassung dringend geboten.

Änderungsantrag Nr. 5

Zu Artikel 3 Nummer 38a (§ 352 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

(Zugriffsbeschränkung für Abrechnungsdaten
der Krankenkassen)

Nach Artikel 3 Nummer 38 wird die folgende Nummer 38a eingefügt:

„38a. In § 352 wird nach Satz 2 der folgende Satz eingefügt:

„Die Zugriffsrechte nach Satz 1 gelten nicht für Daten nach § 341 Absatz 2 Nummer 8.“ ‘

Begründung:

Die Änderung von § 352 bezweckt die Einschränkung des Zugriffs auf Daten nach § 341 Absatz 2 Nummer 8 SGB V. Gegenüber der bisherigen Rechtslage, die lediglich die Möglichkeit eines Widerspruchs gegen die Übermittlung dieser Daten eröffnet, wird durch die eingeschränkte Zugriffsmöglichkeit ein höheres Schutzniveau der Versicherten vor der indirekten Offenbarung von sensiblen Informationen garantiert.

Änderungsantrag Nr. 6

Zu Artikel 3 Nummer 39 (§ 360 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

(Anpassung der Fristen zum Anschluss der Heil- und Hilfsmittelerbringer an die Telematikinfrastruktur)

Artikel 3 Nummer 39 wird durch die folgende Nummer 39 ersetzt:

„39. § 360 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 8 wird die Angabe „1. Januar 2026“ durch die Angabe „1. Oktober 2027“ ersetzt.
- b) Absatz 10 wird durch den folgenden Absatz 10 ersetzt:

„(10) Die Gesellschaft für Telematik ist verpflichtet, die Komponenten der Telematikinfrastruktur, die den Zugriff der Versicherten auf die elektronische ärztliche Verordnung nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 ermöglichen, als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Die Funktionsfähigkeit und Interoperabilität der Komponenten sind durch die Gesellschaft für Telematik sicherzustellen. Die Sicherheit der Komponenten des Systems zur Übermittlung ärztlicher Verordnungen einschließlich der Zugriffsmöglichkeiten für Versicherte ist durch ein externes Sicherheitsgutachten nachzuweisen. Dabei ist abgestuft im Verhältnis zum Gefährdungspotential nachzuweisen, dass die Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit der Komponenten sichergestellt werden. Die Festlegung der Prüfverfahren und die Auswahl des Sicherheitsgutachters für das externe Sicherheitsgutachten erfolgt durch die Gesellschaft für Telematik im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das externe Sicherheitsgutachten muss dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zur Prüfung vorgelegt und durch dieses bestätigt werden. Erst mit der Bestätigung des externen Sicherheitsgutachtens durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik dürfen die Komponenten durch die Gesellschaft für Telematik zur Verfügung gestellt werden. Komponenten nach diesem Absatz, für die ein externes Sicherheitsgutachten vorliegt, das gemäß Satz 6 durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bestätigt wurde, dürfen den Versicherten abweichend von Satz 7 auch durch die Krankenkassen und durch die in § 362 Absatz 1 genannten Kostenträger über die Benutzeroberfläche gemäß § 342 zur Verfügung gestellt werden. § 11 Absatz 1 und 1a des Apothekengesetzes sowie § 31 Absatz 1 Satz 5 bis 7 bleiben unberührt.“ ‘

Begründung:

Zu Buchstabe a

Die Einführung der elektronischen Heilmittelverordnung und der Hilfsmittelverordnung werden sich nach hinten verschieben. Das hat zur Folge, dass auch die Verpflichtung für Heilmittelerbringer und für Hilfsmittelerbringer zum Anschluss an die Telematikinfrastruktur zeitlich nach hinten verschoben werden muss.

Zu Buchstabe b

Die Regelung entspricht wortgleich dem Gesetzentwurf und muss im Änderungsantrag aus rein redaktionellen Gründen wiederholt werden.

Änderungsantrag Nr. 7

Zu Artikel 3 Nummer 0 (§ 6 SGB V)

(Schließung von Regelungslücken beim Ausschluss über-55-jähriger PKV-Versicherter aus der GKV)

Vor Artikel 3 Nummer 1 wird die folgende Nummer 0 eingefügt:

,0. § 6 Absatz 3a wird durch die folgenden Absätze 3a und 3b ersetzt:

„(3a) Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres versicherungspflichtig werden, sind versicherungsfrei, wenn sie in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Versicherungspflicht nicht gesetzlich versichert waren. Weitere Voraussetzung ist, dass diese Personen mindestens die Hälfte dieser Zeit versicherungsfrei, von der Versicherungspflicht befreit oder nach § 5 Absatz 5 nicht versicherungspflichtig waren. Entfällt für diese Personen die Versicherungsfreiheit, die Befreiung von der Versicherungspflicht oder die hauptberufliche selbstständige Erwerbstätigkeit nach Vollendung des 55. Lebensjahres, gelten die Versicherungsfreiheit, die Befreiung von der Versicherungspflicht oder die wegen hauptberuflich selbstständiger Erwerbstätigkeit nicht bestehende Versicherungspflicht nach § 5 Absatz 5 als im Sinne des Satzes 2 fortbestehend. Der Voraussetzung nach Satz 2 auch in Verbindung mit Satz 3 steht die Ehe oder die Lebenspartnerschaft mit einer in den Sätzen 2 und 3 genannten Person gleich. Satz 1 gilt nicht für Personen, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 13 versicherungspflichtig sind.

(3b) Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres eine Absicherung im Krankheitsfall begründen, die nach zwischenstaatlichen oder supranationalen Vorschriften einer Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung gleichgestellt ist, sind, auch wenn sie nach Begründung dieser Absicherung im Krankheitsfall nach diesem Buch versicherungspflichtig werden, versicherungsfrei, wenn sie in den letzten fünf Jahren vor der Begründung dieser Absicherung im Krankheitsfall nicht gesetzlich versichert waren und mindestens die Hälfte dieser Zeit versicherungsfrei, von der Versicherungspflicht befreit oder nach § 5 Absatz 5 nicht versicherungspflichtig waren. Absatz 3a Satz 4 gilt entsprechend.“ ‘

Begründung:

Mit der Regelung wird eine Regelungslücke für Personen geschlossen, die bereits das 55. Lebensjahr vollendet haben, deren Versicherungspflichttatbestand aber erst nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben eintritt.

Gemäß § 6 Absatz 3a Satz 1 sind Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres versicherungspflichtig werden, versicherungsfrei, wenn sie in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Versicherungspflicht nicht gesetzlich versichert waren. Hierdurch wird zum Schutz der Solidargemeinschaft sichergestellt, dass Personen, die versicherungsfrei, von der Versicherungspflicht befreit oder hauptberuflich selbstständig tätig waren, nicht zu diesem späten Zeitpunkt in ihrem Erwerbsleben von der privaten Krankenversicherung zurück in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln können, obwohl sie im vergangenen Fünfjahreszeitraum der Sphäre der privaten Krankenversicherung zuzuordnen waren.

Zu dieser Abgrenzung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg am 19. April 2024 (Az. L 1 KR 441/21) entschieden, dass die weitere Voraussetzung in § 6 Absatz 3a Satz 2 „mindestens die Hälfte dieser Zeit versicherungsfrei, von der Versicherungspflicht befreit oder nach § 5 Absatz 5 nicht versicherungspflichtig“ dem Wortlaut nach auf den in § 6 Absatz 3a Satz 1 enthaltenen Fünfjahreszeitraum zu beziehen ist, der mit Eintritt der Versicherungspflicht endet und nicht mit dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben. Diese Auslegung hat

zur Folge, dass die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung frühestens zweieinhalb Jahre nach dem durch das Ausscheiden aus dem Berufsleben bedingten Ende der Versicherungsfreiheit, dem Ende einer hauptberuflichen selbstständigen Erwerbstätigkeit (nach § 5 Absatz 5 nicht versicherungspflichtig) oder dem Wegfall einer Befreiung von der Versicherungspflicht einen Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung eröffnet. Eine solche Aushöhlung der grundsätzlichen Systemabgrenzung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung entsprach nicht der Intention des Gesetzgebers.

Im Hinblick auf die Rechtsprechung ist daher mittels der neuen Regelung Abhilfe zu schaffen. Nach dieser wirkt für Zwecke der Voraussetzung des Satzes 2 eine nach Vollendung des 55. Lebensjahres wegfallende Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht oder hauptberufliche selbstständige Erwerbstätigkeit (nach § 5 Absatz 5 nicht versicherungspflichtig) fort. Grundsätzlich haben sich diese Personen (weiterhin) in der privaten Krankenversicherung abzusichern. Für der privaten Krankenversicherung zugeordnete Personen besteht dabei Anspruch auf Aufnahme in den Basis-tarif.

Im vormaligen Satz 3 und neuen Satz 4 werden Folgeänderung zum neu eingefügten Satz 3 vorgenommen. Die erweiternde Regelung des neuen Satzes 3 erfasst gleichfalls auch Ehegatten und Lebenspartner von Beamtinnen und Beamten, hauptberuflich selbstständige Erwerbstätigen und versicherungsfreien Personen.

Wenn privat Krankenversicherte ins Ausland ziehen und dort eine Absicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten, können zwischenstaatliche oder supranationale Normen die Anerkennung von im Ausland zurückgelegten Zeiten in einer gesetzlichen Absicherung anordnen. Solche Regelungen bezwecken die Gleichstellung mit gesetzlich Versicherten im Inland, nicht jedoch eine Besserstellung im Vergleich zu Versicherten mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland. Die systembedingten Einschränkungen bei der Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) sollten durch derartige Vorschriften nicht umgangen werden können.

Eine fundamentale Bestimmung zur Systemabgrenzung zwischen GKV und privater Krankenversicherung ist § 6 Absatz 3a, nach dem ein Wechsel in die GKV nach Vollendung des 55. Lebensjahres nur noch sehr eingeschränkt möglich ist, wenn in den letzten fünf Jahren zuvor schon eine Versicherung in der GKV bestanden hat oder die betreffenden Personen nicht einer Personengruppe angehören, die, wie zum Beispiel als Jahresarbeitsentgeltüberschreiter und Beamte versicherungsfrei oder als hauptberuflich Selbstständige nicht versicherungspflichtig und damit grundsätzlich der PKV zugewiesen sind. Mit der Regelung sollen Wechsel in die GKV unterbunden werden, wenn während der aktiven Erwerbsphase keine ausreichende Beteiligung an der solidarischen Finanzierung der GKV stattgefunden hat.

Personen, die vor einem Auslandsaufenthalt bereits in Deutschland ansässig waren, konnten bzw. hatten sich in Deutschland gegen Krankheit abzusichern. Von Sondersicherungssystemen abgesehen ist hierfür nach den gesetzlichen Regelungen entweder eine Absicherung in der GKV oder in der PKV möglich bzw. vorgesehen. Die im Gesetz enthaltene Systemabgrenzung sollte durch einen Auslandsaufenthalt nicht umgangen werden können. Daher ist die Systemabgrenzung in § 6 dahingehend zu präzisieren, dass die ausschließenden Voraussetzungen für eine Aufnahme in die GKV nach Vollendung des 55. Lebensjahres auch bei Personen, die nach einem Aufenthalt im Ausland nach Deutschland ziehen, wirkungsgleich zur Anwendung kommen. Damit ein Aufenthalt im Ausland weder zu einer Benachteiligung noch zu einer Bevorzugung im Vergleich zu durchgängig im Inland Versicherten führt, sind die Voraussetzungen bei erstmaliger Wahl einer gesetzlichen Absicherung nach Vollendung des 55. Lebensjahrs zu prüfen, unabhängig davon, ob diese im Inland oder im Ausland erfolgt.

Da die Regelung keine Einschränkungen enthält, gilt sie für sämtliche Versicherungspflichttatbestände nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 bis 13. Sofern vor dem Aufenthalt im Ausland eine private Krankenversicherung bestanden hat, können Versicherte ihren Vertrag als Anwartschaftsversicherung fortführen (§ 204 Absatz 5 des Versicherungsvertragsgesetzes). Anderenfalls besteht Anspruch auf Aufnahme in den Basistarif.

Änderungsantrag Nr. 8

Zu Artikel 3 Nummer 0 (§ 10 SGB V)

(Ausschluss des Wechsels aus der privaten Krankenversicherung in die Familienversicherung der GKV durch Absenken einer gesetzlichen Altersrente auf eine Teilrente)

Vor Artikel 3 Nummer 1 wird die folgende Nummer 0 eingefügt:

,0. § 10 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von familienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehörigen

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben,
2. nicht nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 11 bis 12 oder nicht freiwillig versichert sind,
3. nicht versicherungsfrei oder nicht von der Versicherungspflicht befreit sind,
4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind und
5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches überschreitet.

Die Versicherungsfreiheit nach § 7 bleibt bei der Prüfung der Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 3 außer Betracht. Bei Abfindungen, Entschädigungen oder ähnlichen Leistungen (Entlassungsentschädigungen), die wegen der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses in Form nicht monatlich wiederkehrender Leistungen gezahlt werden, wird zur Ermittlung des Gesamteinkommens nach Satz 1 Nummer 5 das zuletzt erzielte monatliche Arbeitsentgelt für die der Auszahlung der Entlassungsentschädigung folgenden Monate bis zu dem Monat berücksichtigt, in dem im Fall der Fortzahlung des Arbeitsentgelts die Höhe der gezahlten Entlassungsentschädigung erreicht worden wäre. Renten werden für das Gesamteinkommen nach Satz 1 Nummer 5 mit dem Zahlbetrag ohne den auf Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten entfallenden Teil berücksichtigt. Für Familienangehörige, die eine geringfügige Beschäftigung nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 des Vierten Buches oder § 8a des Vierten Buches in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Nummer 1 des Vierten Buches ausüben, ist ein regelmäßiges monatliches Gesamteinkommen im Sinne des Satzes 1 Nummer 5 bis zur Geringfügigkeitsgrenze zulässig. Eine hauptberufliche selbständige Tätigkeit im Sinne des Satzes 1 Nummer 4 ist nicht deshalb anzunehmen, weil eine Versicherung nach § 1 Absatz 3 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte besteht. Ehegatten und Lebenspartner sind abweichend von Satz 1 für die Dauer der Schutzfristen nach § 3 des Mutterschutzgesetzes und für die Dauer der Elternzeit nicht versichert, wenn sie zuletzt vor diesen Zeiträumen nicht gesetzlich krankenversichert waren. Ehegatten und Lebenspartner sind abweichend von Satz 1 nicht versichert, wenn sie

1. eine Rente wegen Alters als Teilrente in Anspruch nehmen,
2. die in Satz 1 Nummer 5 genannte Voraussetzung nicht erfüllen würden, wenn sie die Rente stattdessen in voller Höhe in Anspruch nehmen würden und
3. zuletzt vor Inanspruchnahme der Teilrente nicht gesetzlich krankenversichert waren.“ ‘

Begründung:

Die neuen Sätze 2 bis 6 entsprechen der bestehenden Rechtslage und waren bisher in der listenförmigen Aufzählung in Satz 1 enthalten. Sie regeln nähere Bestimmungen zu den Voraussetzungen in Satz 1 und wurden nun im Anschluss an die Aufzählung in eigene Sätze überführt, um die Regelung insgesamt übersichtlicher zu gestalten.

Bei der Ergänzung des Satzes 7 (bisher Satz 3) handelt es sich um eine Klarstellung, dass mit der Regelung von der grundsätzlichen Regelung in Satz 1 abgewichen wird.

Mit dem neuen Satz 8 wird der Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) über die beitragsfreie Familienversicherung für privat versicherte Rentnerinnen und Rentner ausgeschlossen, deren Zahlbetrag der Vollrente oberhalb der Gesamteinkommensgrenze der Familienversicherung liegt und die nur durch die Wahl einer Rente wegen Alters als Teilrente die Voraussetzungen für die Familienversicherung erfüllen. Mit der Regelung wird auf vermehrte Fälle reagiert, in denen privat krankenversicherte Rentnerinnen und Rentner durch ein gezieltes, temporäres Absenken ihres Rentenzahlbetrags Zugang zur GKV über ihre Ehegattin und Ehegatten erhalten. Die Regelung schließt insoweit eine Gesetzeslücke in der Systemabgrenzung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung und dient dem Schutz der Solidargemeinschaft. Mit der Regelung wird die Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers bekräftigt, dass Personen, die sich gegen die solidarische Beitragstragung in der GKV zu Zeiten ihres Erwerbslebens entschieden haben, nicht im Alter in die GKV zurückkehren sollen.

Änderungsantrag Nr. 9

Zu Artikel 3 Nummer 18 (§ 87 SGBV)

(Überprüfungsauftrag - Barrierefreiheit des EBM)

Artikel 3 Nummer 18 wird durch die folgende Nummer 18 ersetzt:

„18. § 87 wird wie folgt geändert:

- a) Nach Absatz 2 Satz 8 wird der folgende Satz eingefügt:
„Die Bewertungsmaßstäbe sind regelmäßig daraufhin zu überprüfen, ob sie den besonderen Erfordernissen der Versorgung von behinderten Menschen angemessen Rechnung tragen und, soweit erforderlich, anzupassen; die Anpassung ist zum Zeitpunkt der Anpassung punktsummenneutral umzusetzen.“
- b) Absatz 2a Satz 9 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
„In die Überprüfung nach Absatz 2 Satz 2 ist auch einzubeziehen, in welchem Umfang nach § 28 Absatz 1 Satz 2 delegationsfähige Leistungen und nach § 73d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 vereinbarte Leistungen durch andere Personen qualifiziert erbracht und angemessen vergütet werden können; auf dieser Grundlage ist eine Anpassung des einheitlichen Bewertungsmaßstabes für ärztliche Leistungen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Versorgungsstrukturen zu beschließen.“ ‘

Begründung:

Zu Buchstabe a

Die Regelung stellt sicher, dass durch die regelmäßige Überprüfung der einheitlichen Bewertungsmaßstäbe für die ärztlichen und zahnärztlichen Leistungen dem Ziel der angemessenen Berücksichtigung der barrierefreien Leistungserbringung Rechnung getragen wird. Soweit aufgrund der Überprüfung eine Anpassung der Bewertungsmaßstäbe erforderlich ist, stellt die Regelung zudem sicher, dass sich durch die Anpassung zum Zeitpunkt der Anpassung das in Punkten bestimmte Leistungsvolumen insgesamt nicht erhöht.

Zu Buchstabe b

Die Regelung entspricht dem Gesetzentwurf.

Änderungsantrag Nr. 10

Zu Artikel 3 Nummer 21a (§ 117 SGB V)

Zu Artikel 3 Nummer 22a (§ 120 SGB V)

(Finanzierung Psychotherapeuten in Weiterbildung)

Artikel 3 wird wie folgt geändert:

1. Nach Nummer 21 wird die folgende Nummer 21a eingefügt:

„21a. § 117 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 3b Satz 1 wird nach der Angabe „zugelassen sind“ die Angabe „(Weiterbildungsambulanzen)“ eingefügt.
- b) Absatz 3c wird durch den folgenden Absatz 3c ersetzt:
„Für die Vergütung der in den Ambulanzen nach den Absätzen 3 und 3a erbrachten Leistungen gilt § 120 Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass dabei eine Abstimmung mit Entgelten für vergleichbare Leistungen erfolgen soll. § 120 Absatz 3 Satz 2 und 3 und Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend. Die Ambulanzen sind verpflichtet, von der Vergütung, die sie von den Krankenkassen für die durch einen Ausbildungsteilnehmer erbrachte Leistung erhalten, jeweils einen Anteil in Höhe von mindestens 40 Prozent an den jeweiligen Ausbildungsteilnehmer auszuzahlen. Sie haben die Auszahlung des Vergütungsanteils den Krankenkassen nachzuweisen. Die Ambulanzen haben der Bundespsychotherapeutenkammer die jeweils aktuelle Höhe der von den Ausbildungsteilnehmern zu zahlenden Ausbildungskosten sowie des auszahlenden Vergütungsanteils mitzuteilen. Die Bundespsychotherapeutenkammer hat eine bundesweite Übersicht der nach Satz 5 mitgeteilten Angaben zu veröffentlichen.“ ‘

2. Nach Nummer 22 wird die folgende Nummer 22a eingefügt:

„22a. § 120 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

„Die Leistungen der Hochschulambulanzen, der Weiterbildungsambulanzen, der psychiatrischen Institutsambulanzen, der sozialpädiatrischen Zentren und der medizinischen Behandlungszentren werden unmittelbar von der Krankenkasse vergütet. Die Vergütung wird von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich mit den Hochschulen oder Hochschulkliniken, den Weiterbildungsambulanzen, den Krankenhäusern oder den sie vertretenden Vereinigungen im Land vereinbart; die Höhe der Vergütung für die Leistungen der jeweiligen Hochschulambulanz gilt auch für andere Krankenkassen im Inland, wenn deren Versicherte durch diese Hochschulambulanz behandelt werden. Sie muss die Leistungsfähigkeit der in Satz 1 genannten Leistungserbringer bei wirtschaftlicher Betriebsführung gewährleisten. Bei der Vergütung der Leistungen der Hochschulambulanzen sind die Grundsätze nach Absatz 3 Satz 4 erstmals bis zum 1. Juli 2017 und danach jeweils innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Anpassung der Grundsätze nach Absatz 3 Satz 4 zu berücksichtigen. Bei den Vergütungsvereinbarungen für Hochschulambulanzen nach Satz 2 sind Vereinbarungen nach Absatz 1a Satz 1 zu berücksichtigen. Als Bestandteil der Vereinbarung nach Satz 2 ist eine Vergütung für die telemedizinische Erbringung von Leistungen durch die Einrichtungen nach Satz 1 festzulegen. Abweichend von den Sätzen 2 und 3 hat die Vergütung der Leistungen, die die psychiatrischen Institutsambulanzen im Rahmen der Versorgung nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92

Absatz 6b erbringen, nach den entsprechenden Bestimmungen im einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen mit dem Preis der jeweiligen regionalen Euro-Gebührenordnung zu erfolgen. Bei der Vereinbarung der Vergütung der ambulanten psychotherapeutischen Behandlung in den Weiterbildungsambulanzen hat eine Abstimmung mit Entgelten für vergleichbare Leistungen zu erfolgen. Für die Beurteilung einer wirtschaftlichen Betriebsführung der Weiterbildungsambulanzen sind nur die Leistungen berücksichtigungsfähig, für die der Zulassungsausschuss eine Ermächtigung erteilt hat und die gegenüber Versicherten erbracht werden.“ ‘

Begründung:

Zu Nummer 1 (§ 117 SGB V)

Zu Buchstabe a

Mit der Änderung wird für die Ambulanzen an Einrichtungen, die nach Landesrecht für die Weiterbildung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder Ärztinnen und Ärzten in psychotherapeutischen Fachgebieten zugelassen sind, die Legaldefinition der Weiterbildungsambulanzen eingeführt, damit dieser Begriff im Gesetz verwendet werden kann.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um Folgeänderungen, die daraus resultieren, dass für die Weiterbildungsambulanzen die Möglichkeit geschaffen wird, ihre Vergütungen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen nach § 120 Absatz 2 zu vereinbaren. Die entsprechende Verweisung in Absatz 3c auf die Weiterbildungsambulanzen nach Absatz 3b ist mithin obsolet. Entsprechend ist auch die Regelung der Weitergabe von mindestens 40 Prozent der von den Krankenkassen geleisteten Vergütung an die Weiterbildungsteilnehmenden hinfällig sowie die Mitteilung der Höhe der Ausbildungskosten und des auszuzahlenden Vergütungsanteils. Die Nennung der Weiterbildungsteilnehmenden ist aus der jeweiligen Regelung zu streichen.

Zu Nummer 2 (§ 120 SGB V)

Durch die Änderung in Absatz 2 Satz 1 und dem entsprechende notwendige Folgeänderungen in den Sätzen 2 und 3 werden die Weiterbildungsambulanzen nunmehr explizit in § 120 Absatz 2 genannt und insoweit mit den bereits benannten Hochschulambulanzen, psychiatrischen Institutsambulanzen, sozialpädiatrischen Zentren und den medizinischen Behandlungszentren gleichgestellt.

Durch die Ergänzung der Sätze 8 und 9 wird als Maßstab für die Festlegung der Vergütung der Weiterbildungsambulanzen eine Abstimmung mit Entgelten für vergleichbare Leistungen vorgegeben. Auch dürfen nur Leistungen vergütet werden, für die eine Ermächtigung des Zulassungsausschusses vorliegt und die gegenüber Versicherten erbracht werden. Für andere Aufgaben, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang zu der Leistungserbringung gegenüber einem Versicherten stehen, besteht keine Leistungspflicht der Krankenkassen und sind somit nicht zu vergüten. Da in den Weiterbildungsambulanzen die Leistungen durch Weiterbildungsteilnehmer erbracht werden, die im Rahmen ihrer Weiterbildung durch die jeweiligen Weiterbildungsordnungen der Länder neben der Behandlung von Patientinnen und Patienten weitere Lerninhalte auferlegt bekommen haben, die nicht in die Zuständigkeit des Bundes fallen, sind klare Abgrenzungen für die zu vergütenden Leistungen erforderlich.

Änderungsantrag Nr.11

Zu Artikel 3 Nummer 25a (§ 176 SGB V)

(Klarstellung Antragsfrist für Solidargemeinschaften)

Nach Artikel 3 Nummer 25 wird die folgende Nummer 25a eingefügt:

„25a. § 176 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

„(1) Die Mitgliedschaft in einer Solidargemeinschaft gilt nur dann als anderweitige Absicherung im Krankheitsfall im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 13 und als ein mit dem Anspruch auf freie Heilfürsorge oder einer Beihilfeberechtigung vergleichbarer Anspruch im Sinne des § 193 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 des Versicherungsvertragsgesetzes, wenn die Solidargemeinschaft am 20. Januar 2021 bereits bestanden hat und seit ihrer Gründung ununterbrochen fortgeführt wurde, sie beides dem Bundesministerium für Gesundheit nachweist und auf ihren alle fünf Jahre zu stellenden Antrag hin das Bundesministerium für Gesundheit jeweils das Vorliegen eines testierten Gutachtens über die dauerhafte Leistungsfähigkeit gemäß Absatz 3 bestätigt. Ein Antrag nach Satz 1 kann erstmalig nur bis einschließlich 30. Juni 2026 gestellt werden.“ ‘

Begründung:

Durch das Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1309) wurde eine Bestandschutzregelung für Mitglieder in (privaten) Solidargemeinschaften in § 176 eingeführt, in denen großteils jahrzehntelang vor Einführung der Pflicht zur Absicherung im Krankheitsfall ein Konzept der gemeinschaftlichen Absicherung in Krankheitsfällen gelebt wurde. Dabei handelt es sich um eine eng begrenzte Ausnahmeregelung. An dem grundsätzlich dual ausgestalteten System der Absicherung im Krankheitsfall durch die gesetzliche und die private Krankenversicherung sollte ausdrücklich festgehalten werden und die Errichtung einer neuen Versicherungssäule explizit ausgeschlossen werden. Im Einklang damit scheidet im Fall eines späteren Verlustes der gesetzlichen Anerkennung der Mitgliedschaft als anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall (z. B., wenn die Leistungsfähigkeit der Solidargemeinschaft nach Ablauf eines weiteren 5-Jahreszeitraums nicht erneut nachgewiesen wurde) eine Mitgliedschaft in der davon betroffenen Solidargemeinschaft als anderweitiger Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall aus und es kommen die allgemeinen Regelungen zur Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) oder die private Krankenversicherung, insbesondere § 5 Absatz 1 Nummer 13 SGB V und § 193 Absatz 3 des Versicherungsvertragsgesetz, zur Anwendung (vgl. zum Ganzen die Gesetzesbegründung in Deutscher Bundestag, Drucksache 19/27652, Seite 109 f.)

Solidargemeinschaften, die die in § 176 Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllen, konnten einen Antrag stellen, um zu Gunsten ihrer Mitglieder Bestandschutz zu erlangen. Über vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Regelung bestand ausreichend Zeit für interessierte Solidargemeinschaften, nach interner Willensbildung einen entsprechenden Antrag zu stellen. Von dieser Möglichkeit haben diverse Solidargemeinschaften auch Gebrauch gemacht und dem vom Gesetzgeber gewollten Bestandschutz wurde Genüge getan. Da es mit Blick auf das grundsätzlich bestehende dual ausgestaltete System nicht sachgerecht ist, die interne Entscheidungsfindung über eine etwaige Antragsstellung zeitlich unbegrenzt zu ermöglichen, wird vor dem Hintergrund des bereits verstrichenen mehrjährigen Entscheidungszeitraum geregelt, dass die Möglichkeit zur erstmaligen Antragsstellung nach § 176 Absatz 1 für Solidargemeinschaften nach dem 30. Juni 2026 ausgeschlossen ist.

Änderungsantrag Nr. 12

Zu Artikel 3a (§ 31 Absatz 1a SGB V)

Zu Artikel 14 (Inkrafttreten)

(Verbandmittel)

1. Nach Artikel 3 wird der folgende Artikel 3a eingefügt:

„Artikel 3a Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 31 Absatz 1a Satz 5 wird die Angabe „Bis 60 Monate nach dem Wirksamwerden der Regelung nach Satz 4“ durch die Angabe „Bis zum 31. Dezember 2026“ ersetzt.‘

2. Artikel 14 wird durch den folgenden Artikel 14 ersetzt:

„Artikel 14 Inkrafttreten

- (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am 1. Januar 2026 in Kraft.
- (2) Artikel 3 Nummer 27 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2025 in Kraft.
- (3) Artikel 3a tritt mit Wirkung vom 2. Dezember 2025 in Kraft.
- (4) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.‘

Begründung:

Zu Nummer 1:

Nach der gemäß § 31 Absatz 1a Satz 4 auf der Grundlage von § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 beschlossenen Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses können sonstige Produkte zur Wundbehandlung in die Versorgung nach § 31 Absatz 1 Satz 2 einbezogen werden, sofern sie medizinisch notwendig sind. Nach der Übergangsregelung in § 31 Absatz 1a Satz 5 können bestimmte sonstige Produkte zur Wundbehandlung davon abweichend auch ohne Nachweis, dass sie medizinisch notwendig sind, noch bis zum 2. Dezember 2025 zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden. Um den Zugang zu diesen Produkten auch nach Ablauf dieser Frist zu gewährleisten, soll die Frist bis zum 31. Dezember 2026 verlängert werden. In einem weiteren Gesetzgebungsverfahren soll im Anschluss der Begriff „Verbandmittel“ so definiert werden, dass langfristig eine Versorgung mit notwendigen Verbandmitteln und Wundbehandlungsprodukten sichergestellt ist.

Zu Nummer 2:

Ein Inkrafttreten der Änderung des § 31 Absatz 1a Satz 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch am 2. Dezember 2025 ist erforderlich, um die bisher geltende Frist, die am 2. Dezember 2025 abläuft, zu verlängern.

Änderungsantrag Nr. 13

Zu Artikel 3 Nummer 27a – neu – (§ 226 SGB V)

(Beitragsfreiheit einer Waisenrente bei Ableistung eines Freiwilligendienstes)

Nach Artikel 3 Nummer 27 wird die folgende Nummer 27a eingefügt:

„27a. Dem § 226 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Sind Personen, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 11b versicherungspflichtig sind, durch Ableistung eines Freiwilligendienstes nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder eines vergleichbaren anerkannten Freiwilligendienstes auch nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 versicherungspflichtig, sind die in § 5 Absatz 1 Nummer 11b genannten Leistungen und die in § 237 Satz 3 genannten Leistungen jeweils bis zum Erreichen der jeweiligen in § 10 Absatz 2 Nummer 3 genannten Altersgrenze beitragsfrei.“ ‘

Begründung:

Zu Nummer 27a (§ 226 SGB V)

Nach geltendem Recht entfällt die Beitragsfreiheit der Waisenrente oder entsprechender Hinterbliebenenversorgungsleistungen mit der vorrangigen Versicherungspflicht als Beschäftigte oder Beschäftigter. Die angesprochenen Freiwilligendienste nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz und dem Jugendfreiwilligendienstgesetz und vergleichbare anerkannte Freiwilligendienste unterliegen grundsätzlich der Versicherungspflicht nach § 5 Absatz 1 Nummer 1, da die im Rahmen der Freiwilligendienste geleisteten Tätigkeiten einer Beschäftigung im sozialversicherungsrechtlichen Sinne gleichstehen. Das hierfür geltende Erfordernis der Entgeltlichkeit wird durch das in der Regel gewährte Taschengeld und gegebenenfalls durch die Sachleistungen Verpflegung, Unterkunft und Arbeitskleidung beziehungsweise entsprechende Geldersatzleistungen erfüllt. Insoweit ist nach § 5 Absatz 8 die Versicherungspflicht als Beschäftigte oder Beschäftigter vorrangig vor der Versicherungspflicht nach § 5 Absatz 1 Nummer 11b.

Für Personen, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 versicherungspflichtig sind, bestimmt § 226 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, dass der Zahlbetrag der Rente der gesetzlichen Rentenversicherung und der der Rente vergleichbaren Einnahmen (Versorgungsbezüge) der Beitragsbemessung zugrunde zu legen ist.

Mit der Ergänzung des § 226 um den neuen Absatz 6 werden die Waisenrente oder entsprechende Hinterbliebenenversorgungsleistungen auch während der Ableistung eines Freiwilligendienstes beitragsfrei gestellt, wenn Personen, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 11b versicherungspflichtig sind, durch Ableistung eines Freiwilligendienstes als Beschäftigte versicherungspflichtig werden.

Änderungsantrag Nr. 14

Zu Artikel 3 (Nummer 0x und 46 (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch)

Zu Artikel 13a (Änderung des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts)

Zu Artikel 14 (Inkrafttreten)

(Übergangsregelung Soziales Entschädigungsrecht)

1. Artikel 3 wird wie folgt geändert:

a) Vor Nummer 1 wird die folgende Nummer 0x eingefügt:

„0x. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 427 die folgende Angabe eingefügt:
„§ 428 Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts“.“

b) Nach Nummer 45 wird die folgende Nummer 46 eingefügt:

„46. Nach § 427 wird der folgende § 428 eingefügt:

„§ 428

Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts

Für Personen, die Leistungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz in Verbindung mit dem Bundesversorgungsgesetz erhalten, gelten die Vorschriften des § 5 Absatz 1 Nummer 6, des § 49 Absatz 1 Nummer 3, des § 55 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und 3 sowie Satz 4, des § 62 Absatz 2 Satz 4 sowie Satz 5 Nummer 2, des § 192 Absatz 1 Nummer 3, des § 235 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 Satz 1, des § 242 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5, des § 251 Absatz 1 und des § 294a Absatz 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung weiter.“

2. Nach Artikel 13 wird der folgende Artikel 13a eingefügt:

„Artikel 13a

Änderung des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts

Artikel 32 Nummer 1 und 13 des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 408) geändert worden ist, wird aufgehoben.“

3. Artikel 14 wird durch den folgenden Artikel 14 ersetzt:

„Artikel 14 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 am 1. Januar 2026 in Kraft.

(2) Artikel 3 Nummer 46 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.

(3) Artikel 3 Nummer 27 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2025 in Kraft.

(4) Artikel 13a tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(5) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.“

Begründung:

§ 326 SGB V existiert seit dem 1. Januar 2024 mit zwei unterschiedlichen Regelungsinhalten. Infolge eines gesetzgeberischen Redaktionsversehens im Zusammenhang mit dem am 20. Oktober 2020 in Kraft getretenen Patientendatenschutzgesetz vom 14. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2115) wurde versäumt, § 326 in der Fassung des Gesetzes zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts vom 12.

Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), das insoweit am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist, in das 15. Kapitel des SGB V (Weitere Übergangsvorschriften) zu transferieren, was zur Vermeidung einer Doppelung desselben Paragraphen-Zeichens mit unterschiedlichem Regelungsinhalt im SGB V nunmehr erfolgt. Die mit dem PDSG geschaffene Norm § 326 SGB V, die das Verbot der Nutzung der Telemedizininfrastruktur ohne Zulassung oder Bestätigung regelt, bleibt von der vorgeschlagenen Änderung unberührt.

Änderungsantrag Nr. 15

Zu Artikel 3 Nummer 27b – neu – (§ 221a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

(Verweiskorrektur Bundeszuschuss)

Nach Artikel 3 Nummer 27a wird die folgende Nummer 27b eingefügt:

„27b. § 221a wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 wird nach der Angabe „nach § 8 Absatz 11 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes“ die Angabe „und nach § 8 Absatz 7 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung“ eingefügt.
- b) In Absatz 3 wird nach der Angabe „nach § 8 Absatz 11 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes“ die Angabe „und nach § 8 Absatz 7 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung“ eingefügt.
- c) In Absatz 4 wird nach der Angabe „nach § 8 Absatz 11 Satz 1 des Krankenhausentgeltgesetzes“ die Angabe „und nach § 8 Absatz 7 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung“ eingefügt.“

Begründung:

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2025 soll unter anderem ein ergänzender Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds zur Abgeltung von Aufwendungen der Krankenkassen an die Krankenhäuser aufgrund eines zeitlich befristeten Rechnungszuschlag bei der stationären Behandlung von gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten geleistet werden. Der Rechnungszuschlag soll die Lücke bei den Sofort-Transformationskosten der Krankenhäuser aus den Jahren 2022 und 2023 schließen. Den Rechnungszuschlag sollen sowohl somatische als auch psychiatrische als auch psychosomatische Krankenhäuser erhalten, weshalb das Haushaltsbegleitgesetz entsprechende Rechnungszuschläge in § 8 Absatz 1 Krankenhausentgeltgesetz und in § 8 Absatz 7 Bundespflegesatzverordnung vorsieht. Der Gesetzlichen Krankenversicherung sollen durch den Rechnungszuschlag keine Mehrausgaben entstehen und gleichzeitig durch einen Übertrag einer möglichen Differenz aus den geleisteten ergänzenden Bundeszuschüssen und den durch die Krankenkassen tatsächlich an die Krankenhäuser gezahlten Rechnungszuschlägen an den Krankenhaustransformationsfonds nach § 12b Krankenhausfinanzierungsgesetz sichergestellt werden, dass die bereitgestellten Mittel in voller Höhe zur Finanzierung der Transformation der Krankenhauslandschaft genutzt werden können. Aufgrund eines redaktionellen Versehens wurde jedoch im Rahmen der Abstimmung des Gesetzentwurfs neben dem Verweis auf die im Krankenhausentgeltgesetz adressierten Akutkrankenhäuser der Verweis auf die psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäuser nach der Bundespflegesatzverordnung in § 221a Absatz 1, 3 und 4 gestrichen. Dies hätte zur Folge, dass bei den in Absatz 3 und 4 vorgesehenen Spitzabrechnungen die an die psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäuser nach der Bundespflegesatzverordnung im Zeitraum von November 2025 bis Oktober 2026 ausgezahlten Rechnungszuschläge bei der Ermittlung des Differenzbetrages nicht berücksichtigt würden. Somit würde der Restmittelübertrag aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds an den Krankenhaustransformationsfonds um diesen Betrag höher ausfallen und die gesetzliche Krankenversicherung in nicht intendierter Weise belastet. Die Änderung korrigiert dieses Versehen.

Änderungsanträge

der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ausschuss für Gesundheit zum Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BT-Drs. 21/1511)

ÄA	Art.	Gesetz	Stichwort	Beschreibung	S.
1	Art. 1 Nr. 9a	§ 10a SGB XI	Gesetzliche Verankerung des Amtes der oder des Beauftragten der Bundesregierung für Pflege	Wiederaufnahme der gesetzlichen Verankerung des Amtes der oder des Beauftragten der Bundesregierung für Pflege, wie im Gesetzentwurf des rot-grünen Bundeskabinetts vom 18. Dezember 2024 vorgesehen. Denn die Mitsprache- und Beteiligungsrechte des Amtes sind wichtig, um die Belange pflegebedürftiger Menschen, ihrer An- und Zugehörigen und der beruflich Pflegenden angemessen vertreten zu können.	3
2	Art. 1 Nr.18	§ 28 SGB XI	Streichung der Zuordnung von heilkundlichen Leistungen durch Pflegefachpersonen zur medizinischen Behandlungspflege in stationären Pflegeeinrichtungen	Der Gesetzentwurf der Regierungskoalition aus Union und SPD sieht vor, die Leistungen nach § 15a SGB V in stationären Pflegeeinrichtungen der medizinischen Behandlungspflege zuzuordnen. Das kann im Ergebnis bedeuten, dass Einrichtungen, die heilkundliche Tätigkeiten durch Pflegefachpersonen nach § 15a SGB V anbieten, teuer und damit weniger wettbewerbsfähig sind als solche, die dies nicht tun. Deshalb wird die Formulierung gestrichen.	6
3	Art. 1 Nr. 66	§ 114a SGB XI	Streichung der längeren Ankündigungsfrist für Qualitätsprüfungen	Der Gesetzentwurf sieht vor, die Ankündigungsfrist für Qualitätsprüfungen von einem Tag auf zwei Arbeitstage anzuheben. Darin ist kein Beitrag zur Entbürokratisierung erkennbar, jedoch eine Abschwächung dieses Instruments zur Sicherung guter Pflegequalität. Insofern wird diese Regelung gestrichen.	8
4	Art. 3 Nr. 2	§ 15a SGB V	Heilkunde-übertragung an Pflegefachpersonen	Für eine effektivere Heilundeübertragung an Pflegefachpersonen werden: - Die Bezeichnung „Leistungen der ärztlichen Behandlung“ von Pflegefachpersonen durch „heilkundliche Leistungen“ ersetzt; - Streichung der ärztlichen Diagnose und Indikationsstellung als Voraussetzung für die eigenverantwortlichen Leistungen von Pflegefachpersonen nach § 15a Abs. 1 Nr. 1; - Die Anforderung einer ärztlichen Verordnung für die Verordnung von häuslicher Krankenpflege durch Pflegefachpersonen gestrichen (Erst-Verordnung von häuslicher Krankenpflege).	9
5	Art. 3 Nr. 2a	§ 15b neu SGB V	Erweiterte heilkundliche Kompetenzen in Notfallsituationen	Mit der Einführung eines neuen § 15b SGB V wird eine rechtliche Grundlage geschaffen, die Pflegefachpersonen mit besonderer notfall- oder akutmedizinischer Qualifikation sowie Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern mit entsprechender Qualifikation eine eigenverantwortliche Heilkundeausübung in klar definierten Notfallsituationen ermöglicht. Das stellt einen wesentlichen Beitrag zur Patientensicherheit, zur Entlastung ärztlicher Ressourcen und zur Weiterentwicklung einer modernen und effizienten Notfallversorgung dar.	11
6	Art. 3 Nr. 4a	§ 27 SGB V	Leistungsrechtliche Verankerung von Behandlungen durch Pflegefachpersonen	Durch die Ergänzung von Behandlungen durch Pflegefachpersonen in § 27 entsteht ein Anspruch der Versicherten auf diese Behandlungen, egal ob sie häuslich gepflegt oder in der stationären Pflege	13

				versorgt werden. Das ist ein unerlässlicher Schritt zur Etablierung der neuen Leistungen in der Praxis.	
7	Art. 3 Nr. 4b	§ 28 SGB V	Abgrenzung von der ärztlichen Behandlung	Eine Ergänzung in § 28 stellt klar, dass die Pflegeprozessverantwortung entsprechen § 15a Abs. 2 den Pflegefachpersonen obliegt und in diesem Sinne abzugrenzen ist von Leistungen, die auf Anordnung unter der Verantwortung von Ärzten stattfinden.	14
8	Art. 3 Nr. 17	§ 81 SGB V	Regelungen zum Kassenärztlichen Notdienst	Für Ärztinnen und Ärzte, die nicht Teil des vertragsärztlichen Systems sind (sogenannte Poolärzte), ist für eine Tätigkeit im Notdienst durch die Satzungen der Kassenärztlichen Vereinigungen eine Struktur zu schaffen, die eine angestellte, sozialversicherungspflichtige Tätigkeit vorsieht.	15
9	Art. 3 Nr. 18a	§ 92 SGB V	Stärkungen der Organisationen der Pflegeberufe im Gemeinsamen Bundesausschuss	Es wird den maßgeblichen Organisationen der Pflegeberufe ein Antrags- und Mitberatungsrecht im Gemeinsamen Bundesausschuss eingeräumt. Dies ist notwendig, um die Interessensvertretung der Pflege in der Selbstverwaltung zu stärken.	16
10	Art. 3 Nr. 34	§ 340 SGB V	Authentifizierung von Pflegepersonal	Die Einrichtungsleitung einer ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtung hat dafür Sorge zu tragen, dass alle beschäftigten Personen über einen gültigen elektronischen Heilberufsausweis oder eine digitale Identität für das Gesundheitswesen verfügen.	18
11	Art. 3 Nr. 41a, Art. 15	§§ 362 SGB V	Verarbeitung/Beantragung Krankenversichertennummern durch private Krankenversicherungsunternehmen	Die privaten Krankenversicherungsunternehmen werden verpflichtet, die KVNR für alle ihre Mitglieder zu vergeben. Dies ist notwendig, damit PKV-Versicherte ebenfalls von den TI-Anwendungen profitieren (E-Rezept, ePA etc.) können.	19

Änderungsanträge

**der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ausschuss für Gesundheit
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung**

**Entwurf eines Gesetzes zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege
(BT-Drs. 21/1511)**

Der Ausschuss für Gesundheit möge beschließen:

Änderungsantrag Nr. 1

Zu Artikel 1 neue Nummer 9a (§ 10a SGB XI)

**(Gesetzliche Verankerung des Amtes der oder des
Beauftragten der Bundesregierung für Pflege)**

Nach Artikel 1 Nummer 9 wird folgende Nummer 9a eingefügt:

, 9a. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt:

„§ 10a

Amt der oder des Beauftragten der Bundesregierung für Pflege

(1) Die Bundesregierung bestellt eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Pflege. Der oder dem Beauftragten für Pflege ist für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgabe die notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Das Amt endet, außer im Fall der Entlassung, mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages.

(2) Aufgabe der oder des Beauftragten für Pflege ist es, darauf hinzuwirken, dass die Anliegen pflegebedürftiger Menschen, ihrer An- und Zugehörigen und der beruflich Pflegenden im Pflege- und Gesundheitssystem wahrgenommen und beachtet werden. Die oder der Beauftragte für Pflege setzt sich bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe dafür ein, dass die Selbstbestimmung der Menschen mit Pflegebedarf gewahrt wird, die Qualität der pflegerischen Versorgung gesichert wird und unterschiedliche Lebensbedingungen und Bedürfnisse beachtet und in allen Bereichen der Versorgung berücksichtigt werden. Die oder der Beauftragte für Pflege wirkt auf eine frühzeitige und umfassende Beteiligung von Menschen mit Pflegebedarf, ihren pflegenden An- und Zugehörigen und beruflich Pflegenden in Fragen der Pflege, insbesondere in Fragen der pflegerischen Versorgung sowie der sozialen und privaten Pflegeversicherung, hin.

(3) Zur Verbesserung der Wahrnehmung der Interessen der Pflegebedürftigen, ihrer Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden wird durch die Beauftragte oder den Beauftragten für Pflege ein Beirat eingerichtet.

(4) Zur Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 2 beteiligen die Bundesministerien die Beauftragte oder den Beauftragten für Pflege bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben, soweit sie Fragen der Pflege behandeln oder berühren. Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des

Bundes unterstützen die Beauftragte oder den Beauftragten für Pflege bei der Erfüllung der Aufgabe.“

Begründung:

Zu § 10a (Amt der oder des Beauftragten der Bundesregierung für Pflege)

Im Entwurf für ein Pflegekompetenzgesetz, der am 18. Dezember 2024 vom damaligen rot-grünen Bundeskabinett beschlossen wurde, war die gesetzliche Verankerung des Amtes der oder des Beauftragten der Bundesregierung für Pflege vorgesehen. Die aktuelle Regierung aus Union und SPD hat diese Regelung aus ihren Entwürfen für das vorliegende Gesetz gestrichen. Diese Änderung ist nicht nachvollziehbar und zum Nachteil für die Pflege in Deutschland. Denn die garantierten Mitsprache- und Beteiligungsrechte des Amtes sind wichtig, um die Belange pflegebedürftiger Menschen, ihrer An- und Zugehörigen und der beruflich Pflegenden angemessen vertreten zu können. Auch der einzurichtende Beirat wäre ein wichtiges Beteiligungsgremium gewesen. Die entsprechenden Regelungen sind deshalb gemäß diesem Änderungsantrag wieder in den Gesetzentwurf aufzunehmen.

Zu Absatz 1

Auf Bundesebene wird den Belangen der Menschen mit Pflegebedarf sowie der beruflich Pflegenden bereits seit 2014 durch die Ernennung einer oder eines Pflegebevollmächtigten mit dem in der Regelung enthaltenen Aufgaben- und Kompetenzspektrum durch Kabinettsbeschluss der Bundesregierung Rechnung getragen. Das Amt hat sich in dieser Form bewährt. Die Stärkung der Pflege und die Berücksichtigung ihrer Belange bei allen Vorhaben hat sich als eine Aufgabe erwiesen, die u.a. aufgrund der fortschreitenden Alterung der Bevölkerung und der Zunahme multimorbider Erkrankungen dauerhaft zu erfüllen ist. Die Bestellung einer oder eines Beauftragten für Pflege wird deshalb mit der Regelung im Gesetz verankert und verstetigt. Durch die gesetzliche Verankerung der Aufgaben der oder des Beauftragten der Bundesregierung für Pflege entstehen dem Bundeshaushalt keine zusätzlichen Haushaltsausgaben.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Aufgabe der oder des Beauftragten für Pflege. Der oder die Beauftragte für Pflege soll in unabhängiger Funktion auf die Beachtung der Belange der Menschen mit Pflegebedarf, ihrer An- und Zugehörigen und der beruflich Pflegenden in allen relevanten Bereichen hinwirken. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Selbstbestimmung von Menschen mit Pflegebedarf. Der oder die Beauftragte für Pflege setzt sich für die Sicherung der Qualität der pflegerischen Versorgung ein. Dies umfasst unter anderem die Unterstützung bei der Implementierung aktueller pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse in die Versorgung.

Zu Absatz 3

Um den Interessen von pflegebedürftigen Menschen, ihren An- und Zugehörigen frühzeitig und fundiert Geltung im Rahmen politischer und gesellschaftlicher Gestaltung pflegerelevanter Entwicklungen verschaffen zu können, richtet der oder die Beauftragte für Pflege einen Beirat ein. Damit werden die Interessen der Pflegebedürftigen und ihrer An- und Zugehörigen konstruktiv Rechnung getragen.

Zu Absatz 4

Die Befugnisse der oder des Beauftragten für Pflege werden weitgehend analog den Vorschriften über die Beauftragte oder den Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen in den §§ 17 und 18 Behindertengleichstellungsgesetz sowie über die Beauftragte oder den Beauftragten für die Belange der Patientinnen und Patienten in § 140h Sozialgesetzbuch Fünftes Buch geregelt. Die Anliegen von pflegebedürftigen Menschen, ihren An- und Zugehörigen sowie der beruflich Pflegenden lassen sich nicht auf den Wirkungsbereich eines oder mehrerer Ministerien beschränken, sie spiegeln sich in vielen Politikbereichen wider. Deshalb regelt Absatz 4 in Anlehnung an § 21 Absatz 1 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) die Zusammenarbeit zwischen den Bundesministerien, den übrigen Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes auf der einen und der oder dem Beauftragten auf der anderen Seite. Das Bundeskabinett kann darüber hinaus ergänzende Regelungen zu Aufgaben und Befugnissen in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) treffen. Absatz 4 enthält die Verpflichtung der Bundesministerien, die Beauftragte oder den Beauftragten zu beteiligen und schreibt allen öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes vor, die Beauftragte oder den Beauftragten bei der Erfüllung der Aufgaben zu unterstützen.

Änderungsantrag Nr. 2

Zu Artikel 1 Nummer 18 (§ 28 SGB XI)

(Streichung der Zuordnung zur medizinischen Behandlungspflege von heilkundlichen Leistungen durch Pflegefachpersonen)

Artikel 1 Nummer 18 wird wie folgt geändert:

Buchstabe c wird durch folgenden Buchstaben c ersetzt:

c) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt:

„ (5) Pflege nach diesem Buch schließt die Erbringung der in § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Fünften Buches genannten Leistungen durch die in § 15a Absatz 1 genannten Pflegefachpersonen ein, die in ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen beschäftigt sind, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung nach dem Fünften Buch erbracht werden. Leistungen anderer Sozialleistungsträger bleiben unberührt.“

Begründung:

In Absatz 5 wird geregelt, dass Pflege nach dem Elften Buch auch die Erbringung von Leistungen nach § 15a Absatz 1 des Fünften Buches umfasst. Damit können Pflegefachpersonen, die bei Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch angestellt sind, heilkundliche Aufgaben und dem Umfang, wie sie in dem Katalog nach § 73d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Fünften Buches vereinbart sind, als Teil der Pflegesachleistungen nach einer vorherigen ärztlichen Diagnose und Indikationsstellung, die hinreichend aktuell sein muss und in der Pflegedokumentation dokumentiert ist, auch in ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen erbringen, sofern sie über die erforderlichen fachlichen Kompetenzen verfügen. Hierfür gelten die Voraussetzungen § 15a Absatz 1 des Fünften Buches entsprechend. In § 15a Absatz 1 des Fünften Buches genannte Leistungen durch Pflegefachpersonen, die in ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung erbracht werden, bleiben unberührt.

Durch die Regelung erhalten zum Beispiel Pflegefachpersonen mit einer Erlaubnis nach § 1 Satz 1 i. V. m. Satz 2 des Pflegeberufgesetzes auch in der Langzeitpflege mehr Befugnisse im Rahmen der Versorgung von Pflegebedürftigen bei einer diabetischen Stoffwechselerkrankung, chronischen Wunden oder Demenz. Soweit von ein ambulanter Pflegedienst Leistungen nach § 37 Absatz 2b Satz 1 zweiter Halbsatz des Fünften Buches erbringt, gehen diese Leistungen § 28 Absatz 5 vor. Die Finanzierungszuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung für die in Absatz 5 genannten Aufgaben bleibt unberührt.

Der Gesetzentwurf der Regierungskoalition aus Union und SPD sieht hingegen vor, die Leistungen nach § 15a SGB V in stationären Pflegeeinrichtungen der medizinischen Behandlungspflege zuzuordnen. Für diese leistet die Pflegeversicherung nach § 43 SGB XI pauschale Leistungsbeträge, sodass die Mehrkosten von den pflegebedürftigen Menschen zu tragen wären. Das kann im Ergebnis bedeuten, dass Einrichtungen, die heilkundliche Tätigkeiten durch Pflegefachpersonen nach § 15a SGB V anbieten, teuer und damit weniger wettbewerbsfähig sind als solche, die dies nicht tun. Dies wäre ein Hindernis für die Übernahme von heilkundlichen Leistungen durch Pflegefachpersonen in der Langzeitpflege und stünde somit dem Ansinnen des Gesetzes grundsätzlich entgegen. Deshalb ist die

Formulierung aus dem Gesetzentwurf zu streichen und stattdessen so zu wählen, wie in diesem Änderungsantrag formuliert.

Änderungsantrag Nr. 3

Zu Artikel 1 Nummer 66 (§ 114a SGB XI)

(Streichung der längeren Ankündigungsfrist für Qualitätsprüfungen)

Artikel 1 Nummer 66 wird wie folgt geändert:

- a) Buchstabe a wird gestrichen.
- b) Die bisherigen Buchstaben b bis e werden zu den Buchstaben a bis d.

Begründung:

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Ankündigungsfrist für Qualitätsprüfungen von Pflegeeinrichtungen nach § 114a SGB XI von einem Tag auf zwei Arbeitstage anzuheben. Dies kann künftig bedeuten, dass eine Prüfung an einem Dienstag schon an einem Freitag angekündigt werden muss, für einen Montag schon an einem Donnerstag. Begründet wird der Schritt u. a. mit Bemühungen zur Entbürokratisierung. Dies ist nicht ganz nachvollziehbar, da die Prüfungen an sich keinen größeren Aufwand zur Vorbereitung produzieren sollten, sondern es um eine Besichtigung des laufenden Betriebs geht. Eine solche Prüfung ist wichtig zur Sicherung einer guten Versorgungsqualität für pflegebedürftige Menschen. Ihr Schutz muss jederzeit im Vordergrund stehen. Vor diesem Hintergrund warnt der Bundesrat in seiner Stellungnahme davor, dass die vorgesehene, längere Ankündigungszeit ein erhebliches Zeitfenster eröffne, in dem eine gezielte Vorbereitung erfolgen könne, etwa durch besondere Herrichtung von Pflegebedürftigen, eine Anpassung der Dienstplangestaltung oder eine Bereinigung der Dokumentation (vgl. BR-Drs. 365/25(B), S. 10). Diese Möglichkeit nicht zu eröffnen ist keine fehlende Vertrauenskultur oder Wertschätzung gegenüber beruflich Pflegenden, wie es die Gesetzesbegründung suggeriert. Bei den Qualitätsprüfungen geht es vielmehr auch um Beratung und eine gemeinsame Sicherstellung von guten Rahmenbedingungen, an denen auch die beruflich Pflegenden ein Interesse haben.

Änderungsantrag Nr. 4

Zu Artikel 3 Nummer 2 (§ 15a SGB V)

(Heilkundeübertragung an Pflegefachpersonen)

Artikel 3 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

, 2. Nach § 15 wird der folgende § 15a eingefügt:

„§ 15a

Behandlung durch Pflegefachpersonen, Pflegeprozessverantwortung

(1) Pflegefachpersonen, die über die erforderlichen fachlichen Kompetenzen aufgrund einer nach dem Pflegeberufegesetz vorgeschriebenen beruflichen oder hochschulischen Ausbildung, aufgrund einer staatlich anerkannten, bundesweit einheitlichen Weiterbildung oder aufgrund einer solchen Weiterbildung entsprechenden Berufserfahrung, die durch eine staatliche Kompetenzfeststellung der Länder nachgewiesen wurde, verfügen, können insbesondere die folgenden heilkundlichen Leistungen im Rahmen der Leistungserbringung nach diesem Buch unter den folgenden Voraussetzungen eigenverantwortlich erbringen:

1. die in den nach § 73d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 112a Absatz 1 vereinbarten Katalogen genannten Leistungen,
2. die Verordnung der in dem nach § 73d Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vereinbarten Katalog genannten Leistungen der häuslichen Krankenpflege, einschließlich der Verordnung der in diesem Katalog als für diese Leistungen benötigt genannten Hilfsmittel nach § 33, und
3. bis zum Abschluss des Vertrags nach § 73d Absatz 1 Satz 1 die in Anlage 1 des nach § 64d Absatz 1 Satz 4 geschlossenen Rahmenvertrags genannten heilkundlichen Leistungen.

(2) Pflegefachpersonen nehmen im Rahmen der Leistungserbringung nach diesem Buch die Pflegeprozessverantwortung im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 des Pflegeberufgesetzes wahr.

(3) Pflegefachpersonen im Sinne dieses Buches sind Personen, die über eine Erlaubnis nach § 1 des Pflegeberufgesetzes verfügen.“

Begründung:

Die Behandlungen durch Pflegefachpersonen sollten als heilkundliche Leistungen definiert werden und nicht als solche der ärztlichen Behandlung, wie es im Gesetzentwurf vorgesehen ist. Dies erscheint geboten, um die Eigenständigkeit des Pflegeberufs, auch in Anbetracht der Vorbehaltsaufgaben nach § 4 PflBG, herauszustellen. Eine entsprechende Bezeichnung war auch im Referentenentwurf zum Pflegekompetenzgesetz der damaligen Ampel-Regierung vorgesehen.

Um die neuen Tätigkeitsfelder von Pflegefachpersonen nicht zu sehr einzuschränken, sollten eigenverantwortliche Behandlungen nicht nur nach ärztlicher Diagnose und Indikationsstellung möglich sein, wie es der Gesetzentwurf vorsieht. Stattdessen sollte ein Katalog an Leistungen erarbeitet werden, die Pflegefachpersonen eigenverantwortlich erbringen können. Insofern ist die Anforderung der ärztlichen Diagnose und Indikationsstellung im Text zu streichen.

Nicht zuletzt sollten Pflegefachpersonen entsprechend ihrer Kompetenzen eine Erstverordnung von Häuslicher Krankenpflege vornehmen können und dafür nicht auf eine vorherige Verordnung durch Ärztinnen und Ärzte angewiesen sein. Deshalb ist auch diese Voraussetzung aus dem Regelungstext zu entfernen.

Änderungsantrag Nr. 5

Zu Artikel 3 neue Nummer 2a (§ 15b SGB V)

(Erweiterte heilkundliche Kompetenzen in Notfallsituationen)

Nach Artikel 3 Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt:

, 2a. Nach § 15a wird der folgende § 15b eingefügt:

„§ 15b

Erweiterte heilkundliche Kompetenzen in Notfallsituationen

(1) Pflegefachpersonen, die über eine besondere notfall- oder akutmedizinische Qualifikation verfügen, sowie Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter mit einer besonderen notfall- oder akutmedizinischen Qualifikation können heilkundliche Leistungen im Rahmen der Leistungserbringung nach diesem Buch eigenverantwortlich erbringen, sofern sie über die erforderlichen fachlichen Kompetenzen verfügen.

(2) Die erforderlichen fachlichen Kompetenzen liegen insbesondere dann vor, wenn sie

1. aufgrund einer nach dem Pflegeberufegesetz oder dem Notfallsanitätergesetz vorgeschriebenen beruflichen oder hochschulischen Ausbildung,
2. aufgrund einer staatlich anerkannten, bundesweit einheitlichen Weiterbildung oder
3. aufgrund einer durch eine staatliche Kompetenzfeststellung der Länder nachgewiesenen, einer solchen Weiterbildung entsprechenden Berufserfahrung

erworben wurden.

(3) Die eigenverantwortliche Erbringung heilkundlicher Leistungen nach Absatz 1 ist zulässig, wenn

1. bei einem Notfall- oder Akutpatientenzustand eine unmittelbare notfallpflegerische oder notfallsanitätsdienstliche Versorgung mindestens vorübergehend erforderlich ist und ohne diese eine unmittelbare und hinreichend wahrscheinliche Verschlechterung des Patientenzustandes angenommen oder nicht ausgeschlossen werden kann, und
2. andere geeignete Versorgungsformen nicht in angemessener Zeit zur Verfügung stehen oder einen unverhältnismäßig großen Aufwand oder zusätzliche Risiken für die Patientin oder den Patienten mit sich bringen würden.

(4) Die heilkundlichen Maßnahmen nach Absatz 1 umfassen auch solche, die über die in den nach § 73d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 112a Absatz 1 vereinbarten Katalogen genannten Leistungen hinausgehen, soweit und solange dies zur Abwendung einer hinreichend wahrscheinlichen akuten Gefahr für Leben oder einer erheblichen Einschränkung der Gesundheit erforderlich ist.

(5) Die Maßnahmen erfolgen unbeschadet der Gesamtverantwortung der Ärztinnen und Ärzte für die medizinische Versorgung.

(6) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Näheres zu Inhalt, Umfang und Anerkennung der in Absatz 2 genannten Qualifikationen sowie zu Verfahren der staatlichen Kompetenzfeststellung nach Absatz 2 Nummer 3 zu regeln.

(7) § 15b gilt ergänzend zu § 15a dieses Gesetzes und zu den Regelungen des Notfallsanitättergesetzes.“

Begründung:

Mit der Einführung eines neuen § 15b SGB V wird eine rechtliche Grundlage geschaffen, die Pflegefachpersonen mit besonderer notfall- oder akutmedizinischer Qualifikation sowie Notfallsanitätterinnen und Notfallsanitättern mit entsprechender Qualifikation eine eigenverantwortliche Heilkundenausübung in klar definierten Notfallsituationen ermöglicht.

Diese Regelung ergänzt § 15a SGB V, der die Übertragung heilkundlicher Leistungen im Regelfall vorsieht, um eine spezifische Notfallregelung. Sie steht zudem im Einklang mit den in § 2a NotSanG vorgesehenen Kompetenzen, indem sie diese berufsrechtlichen Befugnisse leistungsfähig im System der gesetzlichen Krankenversicherung absichert.

Die Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass in vielen akuten und notfallmedizinischen Versorgungslagen eine zeitnahe ärztliche Versorgung nicht in ausreichendem Maße gewährleistet werden kann. Insbesondere im Rettungsdienst, in ländlichen Regionen sowie in Einrichtungen, in denen akutmedizinische Situationen auftreten, muss deshalb sichergestellt sein, dass qualifiziertes Personal die notwendigen heilkundlichen Maßnahmen unverzüglich einleiten kann.

Die eigenverantwortliche Durchführung heilkundlicher Maßnahmen setzt den Nachweis besonderer Qualifikationen voraus, die durch Ausbildung, Weiterbildung oder staatlich anerkannte Kompetenzfeststellung belegt sind. Dadurch wird die Patientensicherheit gewährleistet und zugleich der rechtliche Rahmen für bestehende und künftig zu etablierende notfall-pflegerische und notfallsanitätsdienstliche Konzepte geschaffen.

Mit der Möglichkeit, in Notfallsituationen auch über die bestehenden Leistungskataloge hinauszugehen, wird dem besonderen Versorgungsbedarf in akutmedizinischen Lagen Rechnung getragen. Die Regelung beschränkt sich ausdrücklich auf zeitlich und situativ begrenzte Notfälle und greift nur dann, wenn keine rechtzeitige oder angemessene anderweitige Versorgung zur Verfügung steht.

Die Erweiterung heilkundlicher Kompetenzen für entsprechend qualifizierte Pflegefachpersonen und Notfallsanitätterinnen sowie Notfallsanitätter stellt damit einen wesentlichen Beitrag zur Patientensicherheit, zur Entlastung ärztlicher Ressourcen und zur Weiterentwicklung einer modernen und effizienten Notfallversorgung dar.

Änderungsantrag Nr. 6

Zu Artikel 3 neue Nummer 4a (§ 27 SGB V)

(Leistungsrechtliche Verankerung von Behandlungen durch Pflegefachpersonen)

Nach Artikel 3 Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefügt:

, 4a. § 27 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- a) Nach Satz 1 wird der Satz eingefügt: „Die Krankenbehandlung muss auch die Behandlung durch Pflegefachpersonen als eigenverantwortliche Heilkundenausübung umfassen.“
- b) In Satz 2 wird nach Nummer 6 die folgende Nummer 7 eingefügt:
„7. Behandlungen durch Pflegefachpersonen.“

Begründung:

Die Ergänzung der Behandlungen durch Pflegefachpersonen in § 27 SGB V ist wichtig, um sie leistungsrechtlich zu verankern. So entsteht ein Anspruch der Versicherten auf diese Behandlungen, egal ob sie häuslich gepflegt oder in der stationären Pflege versorgt werden. Das ist ein unerlässlicher Schritt zur Etablierung der neuen Leistungen in der Praxis. Entsprechend ist im Leistungserbringerrecht auch ein neuer § 133 einzufügen.

Änderungsantrag Nr. 7

Zu Artikel 3 neue Nummer 4b (§ 28 SGB V)

(Abgrenzung von der ärztlichen Behandlung)

Nach Artikel 3 Nummer 4a wird folgende Nummer 4b eingefügt:

, 4b. § 28 Absatz 1 Satz 2 wird durch folgenden Satz 2 ersetzt:

„Zur ärztlichen Behandlung gehört auch die Hilfeleistung anderer Personen, die von dem Arzt angeordnet und von ihm zu verantworten ist; § 15a Absatz 2 bleibt unberührt.“

Begründung:

Die Ergänzung stellt klar, dass die Pflegeprozessverantwortung entsprechend § 15a Absatz 2 den Pflegefachpersonen obliegt und in diesem Sinne abzugrenzen ist von Leistungen, die auf Anordnung und unter der Verantwortung von Ärztinnen und Ärzten erbracht werden. Dies ist erforderlich, um das Verhältnis zwischen beiden Bereichen zu regeln und die eigenverantwortliche Leistung durch Pflegefachpersonen in der Praxis abzusichern.

Änderungsantrag Nr. 8

Zu Artikel 3 Nummer 17 (§ 81 SGB V)

(Regelungen zum Kassenärztlichen Notdienst)

Artikel 3 Nummer 17 wird durch folgende Nummer 17 ersetzt:

, 17. Nach § 81 Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 eingefügt:

„(6) Die Satzungen der Kassenärztlichen Vereinigungen sollen Bestimmungen über die Sicherstellung des Notdienstes enthalten, die eine angestellte Tätigkeit für Ärzte vorsehen, die nicht Teil des vertragsärztlichen Systems sind. Sofern dies zum Zwecke der Sicherstellung des Notdienstes in einer Region erforderlich ist, können die Kassenärztlichen Vereinigungen die Gewährung von Sicherstellungspauschalen an die teilnehmenden Ärzte festlegen.“

Begründung:

Die Tätigkeit von Vertragsärzten im Rahmen des Notdienstes wird durch die Änderung in § 95 SGB V als selbstständig eingestuft. Für Ärztinnen und Ärzte, die nicht Teil des vertragsärztlichen Systems sind (sogenannte Poolärzte), ist für eine Tätigkeit im Notdienst durch die Satzungen der Kassenärztlichen Vereinigungen eine Struktur zu schaffen, die eine angestellte, sozialversicherungspflichtige Tätigkeit vorsieht. So wird sichergestellt, dass die Ärztinnen und Ärzte für die Tätigkeit im Notdienst arbeitsrechtlich abgesichert sind, arbeitsrechtliche Vorschriften eingehalten werden und die für die Tätigkeit im Notdienst notwendige Ausstattung durch die Kassenärztliche Vereinigung zur Verfügung gestellt wird. Die dadurch im Vergleich zu einer selbstständigen Tätigkeit für die Ärztinnen und Ärzte sowie die Kassenärztlichen Vereinigungen anfallenden finanziellen Mehraufwände im Rahmen der Beiträge zur Sozialversicherung sind marginal.

Änderungsantrag Nr. 9

Zu Artikel 3 neue Nummer 18a (§ 92 SGB V)

(Stärkung der Organisationen der Pflegeberufe im Gemeinsamen Bundesausschuss)

Nach Artikel 3 Nummer 18 wird folgende Nummer 18a eingefügt:

, 18a. In § 92 SGB V wird nach Absatz 7g der folgende Absatz 7h eingefügt:

„(7h) Bei den Richtlinien zur Verordnung von häuslicher Krankenpflege und außerklinischer Intensivpflege nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 6, den Richtlinien nach Nummer 13 und 14, den Richtlinien nach § 63 Absatz 3c Satz 3 und den Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses nach den §§ 136b und 136c erhalten die maßgeblichen Organisationen der Pflegeberufe auf Bundesebene nach § 118a SGB XI ein Antrags- und Mitberatungsrecht. Gleiches gilt bei den nicht in Satz 1 genannten Richtlinien nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 6, sofern sie die Berufsausübung der Pflegeberufe berühren. Die maßgeblichen Organisationen der Pflegeberufe benennen zur Wahrnehmung des nach den Sätzen 1 und 2 bestehenden Antrags- und Mitberatungsrechts einvernehmlich einen oder zwei Vertreter. Absatz 7e Satz 3 bis 7 gilt entsprechend. Die Vertreter erhalten Reisekosten in entsprechender Anwendung des Bundesreisekostengesetzes, Ersatz des Verdienstausfalls in entsprechender Anwendung des § 41 Absatz 2 des Vierten Buches sowie einen Pauschbetrag für Zeitaufwand in Höhe eines Fünfzigstel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches für jeden Kalendertag einer Sitzung. Der Anspruch richtet sich gegen den Gemeinsamen Bundesausschuss.“

Begründung:

Mit dem neuen Absatz 7h wird den maßgeblichen Organisationen der Pflegeberufe ein Antrags- und Mitberatungsrecht eingeräumt. Damit wird das bislang bestehende allgemeine Beteiligungsrecht bei Richtlinien und Beschlüssen über die Qualitätssicherung (vgl. § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 in Verbindung mit § 136 Absatz 3, § 136a Absatz 5 Satz 5, § 136b Absatz 1 Satz 3) dahingehend erweitert, dass der Vertretung der Berufsorganisationen der Pflegeberufe in den Gremien des G-BA Antrags- und Mitberatungsrechte zustehen. Dies umfasst auch das Recht, Beratungsgegenstände auf die Tagesordnung setzen zu lassen und bei der Beschlussfassung anwesend zu sein. Zudem besteht ein Einvernehmenserfordernis bei Entscheidungen über die Einrichtung einer Arbeitsgruppe und die Bestellung von Sachverständigen durch einen Unterausschuss. Ferner wird das Antrags- und Mitberatungsrecht auch über den Bereich der Qualitätssicherung hinaus auf weitere Aufgabenbereiche des G-BA ausgedehnt, die die Berufsausübung der Pflegeberufe betreffen. Das Antrags- und Mitberatungsrecht besteht danach generell auch bei den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zur Verordnung von häuslicher Krankenpflege und außerklinischer Intensivpflege, der Richtlinie nach § 63 Absatz 3c Satz 3 und der Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungs-Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 14, bei denen die Berufsausübung der Pflegeberufe regelmäßig betroffen ist. Die Berufsausübung der Pflegeberufe kann darüber hinaus auch in weiteren Bereichen der veranlassten Leistungen berührt sein. Dies kann auch bei der ATMP-Qualitätssicherungs-Richtlinie der Fall sein. Der G-BA kann insoweit im Rahmen seiner Verfahrensordnung näher konkretisieren, welche

weiteren Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 die Berufsausübung der Pflegeberufe generell berühren und für welche dies gegebenenfalls nur bei bestimmten Beschlussgegenständen gilt.

Zum Zwecke der Ausübung des Mitberatungs- und Antragsrechts benennen die maßgeblichen Organisationen der Pflegeberufe einvernehmlich einen oder zwei Vertreter oder Vertreterinnen. Das bisherige Beteiligungsrecht der Berufsorganisationen der Pflegeberufe im G-BA wurde in erster Linie vom Deutschen Pflegerat e.V. (DPR) wahrgenommen.

Um sicherzustellen, dass die unmittelbare Einbeziehung der Expertise der Pflege in die Beratungen des G-BA tatsächlich erfolgen kann, kann die Person beziehungsweise können die Personen, die die Vertretung in den Sitzungen der Gremien des G-BA übernimmt beziehungsweise übernehmen, Reisekosten in entsprechender Anwendung des Bundesreisekostengesetzes, Ersatz des Verdienstausfalls sowie einen Pauschbetrag für Zeitaufwand für jeden Kalendertag einer Sitzung erhalten. Die Regelung erfolgt in Anlehnung an die entsprechenden Vorgaben für die Patientenvertretung.

Diese Regelungen fehlen bislang im vorliegenden Gesetzentwurf, obwohl dies eine Befugniserweiterung der Pflegefachpersonen zum Ziel hat, und sind deshalb entsprechend dieses Änderungsantrages aufzunehmen.

Änderungsantrag Nr. 10

Zu Artikel 3 Nummer 34 (§ 340a Fünftes Buch Sozialgesetzbuch)

(Authentifizierung von Pflegepersonal)

Artikel 3 Nummer 34 wird durch folgende Nummer 34 ersetzt:

, 34. Nach § 340 wird der folgende § 340a eingefügt:

„§ 340a

Sicherer Umgang mit Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen

(1) Eine Komponente zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen darf von demjenigen, an den sie ausgegeben wurde, weder entgeltlich noch unentgeltlich unbefugt weitergegeben werden. Bei Aufgabe der Leistungserbringerinstitution hat derjenige, an den eine Komponente zur Authentifizierung von Leistungserbringerinstitutionen ausgegeben wurde, oder dessen Nachfolger deren Sperrung unverzüglich zu veranlassen.

(2) Die Einrichtungsleitung einer ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtung nach dem Elften Buch ist für die Einhaltung der Vorgaben nach Absatz 1 verantwortlich. Die Einrichtungsleitung hat darüber hinaus dafür Sorge zu tragen, dass **alle beschäftigten Personen** über einen gültigen elektronischen Heilberufsausweis oder eine digitale Identität für das Gesundheitswesen nach § 340 Absatz 6 **verfügen**.“

Begründung

Die verpflichtende Nutzung eines gültigen elektronischen Heilberufsausweises oder einer digitalen Identität für das Gesundheitswesen durch alle in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen beschäftigten Personen, die in die medizinische und pflegerische Versorgung von Patienten einbezogen sind, ist von zentraler Bedeutung für die Sicherheit und Integrität der Versorgung. Nur so können sensible Patientendaten, insbesondere beim Zugriff auf die elektronische Patientenakte (ePA), vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Gleichzeitig wird eine eindeutige Authentifizierung jeder handelnden Person gewährleistet, was Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei medizinischen und pflegerischen Entscheidungen stärkt. Die digitale Identifizierung dient damit sowohl dem Schutz der Patientinnen und Patienten als auch der rechtlichen Absicherung der Beschäftigten, da Dokumentationen, Anordnungen und Zugriffe eindeutig zugeordnet werden können. Insgesamt erhöht die Regelung die Datensicherheit, stärkt das Vertrauen in digitale Prozesse im Gesundheitswesen und trägt zu einer verbesserten Qualität der Versorgung bei.

Änderungsantrag Nr. 11

Zu Artikel 3 Nummer 41a neu (§ 362 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch)

Zu Artikel 15 – neu (§ 192 Versicherungsvertragsgesetz)

(Verarbeitung/Beantragung Krankenversichertennummer durch private Krankenversicherungsunternehmen)

1. Nach Artikel 3 Nummer 41 wird folgende Nummer 41a eingefügt:

„28a. In § 362 Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern „§ 290 Absatz 1 Satz 4 bis 7“ die Wörter „und Absatz 3“ eingefügt.“ ‘

2. Nach Artikel 14 wird folgender Artikel 15 eingefügt:

„Artikel 15 Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes

Das Versicherungsvertragsgesetz vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631), das zuletzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 11. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 354) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 192 Absatz 8 wird folgender Absatz 9 angefügt:

„(9) In den Fällen einer Krankheitskostenversicherung nach § 193 Absatz 3 ist der Versicherer verpflichtet, für die versicherte Person die Vergabe des unveränderbaren Teils der Krankenversichertennummer nach § 290 Absatz 1 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zu Versicherungsbeginn zu beantragen. § 290 Absatz 3 Satz 5 und Absatz 4 sowie § 362 Absatz 2 Satz 2 und 3 und Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend. Abweichend von Satz 1 hat der Versicherer die Verpflichtung nach Satz 1 für die bei ihm am [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 14] versicherten Personen spätestens bis zum [einsetzen: Datum des ersten Tages des siebten auf die Verkündung folgenden Monats] zu erfüllen.“

Begründung

Zu Nummer 1

Durch die Änderung wird klargestellt, dass die von den Kostenträgern nach § 362 Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) vergebenen Krankenversichertennummern im Verzeichnis der Krankenversichertennummern nach § 290 Absatz 3 SGB V zu führen sind. Der Datenabgleich, um Mehrfachvergaben derselben Krankenversichertennummer auszuschließen oder zu korrigieren, erfolgt innerhalb des von der Vertrauensstelle nach § 362 Absatz 2 SGB V geführten Registers.

Zu Nummer 2

Die Änderung stellt klar, dass die privaten Krankenversicherungsunternehmen unmittelbar zur Vergabe der Krankenversichertennummer an ihre Versicherten verpflichtet sind. Die Krankenversichertennummer ist für sämtliche Versicherte zu vergeben.

Der Versicherer wendet sich dazu mit den erforderlichen Angaben an die Vertrauensstelle nach § 290 SGB V. Diese vergibt die Versichertennummer entsprechend den Vorgaben der Richtlinien nach § 290 Absatz 2 Satz 1 SGB V (§ 362 Absatz 2 Satz 3 SGB V).

Mit Satz 3 wird ein verbindliches Datum festgelegt, bis zu dem die Beantragung der Vergabe der Krankenversichertennummer an die Bestandsversicherten abgeschlossen sein muss.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Versicherten erfolgt auf der Grundlage des Artikels 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c und des Artikels 9 Absatz 2 Buchstaben b und i Datenschutz-Grundverordnung zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht der Krankenversicherungsträger und aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Durch die Vergabe der KVNR wird ein hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandard bei Medizinprodukten durch Teilnahme an Registern oder durch Nutzung der Telematikinfrastruktur (TI) zur Bereitstellung digitaler Angebote im Gesundheitswesen, insbesondere der Anwendungen nach § 334 Absatz 1 Satz 2 SGB V, gewährleistet. Auf die Einwilligung der betroffenen Personen zur Vergabe der KVNR kommt es insoweit nicht an.

Die Krankenversichertennummer kann gemäß § 362 Absatz 2 Satz 1 SGB V von dem privaten Krankenversicherungsunternehmen umfassend für den Einsatz elektronischer Gesundheitskarten oder digitaler Identitäten zur Verarbeitung von Daten in Anwendungen der Telematikinfrastruktur nach § 334 Absatz 1 Satz 2 SGB V genutzt werden.

Änderungsantrag

der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ausschuss für Gesundheit

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BT-Drs. 21/1511)

ÄA	Art.	Gesetz	Stichwort	Beschreibung	S.
12	Art. 1 Nr. 40 und Nr. 62	§§ 69 und 113 b SGB XI	Konkretisierung des Sicherstellungsauftrages	Der Qualitätsausschuss wird mit der Aufgabe betraut, eine Definition von regionaler pflegerischer Unterversorgung anhand von bundeseinheitlichen Kriterien zu entwickeln. Diese sollen als Grundlage für die Evaluation der Versorgungssituation dienen, die die Pflegekassen im Rahmen ihres Sicherstellungsauftrages zu berücksichtigen haben.	2

Änderungsantrag

**der Abgeordneten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ausschuss für Gesundheit
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung**

**Entwurf eines Gesetzes zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege
(BT-Drs. 21/1511)**

Der Ausschuss für Gesundheit möge beschließen:

Änderungsantrag Nr. 12

Zu Artikel 1 Nummer 40 (§ 69 SGB XI)

Zu Artikel 1 Nummer 62 (§ 113b SGB XI)

(Konkretisierung des Sicherstellungsauftrages)

1. Artikel 1 Nummer 40 wird durch folgende Nummer 40 ersetzt:

, 40. § 69 wird durch den folgenden § 69 ersetzt:

„§ 69

Sicherstellungsauftrag

(1) Die Pflegekassen haben im Rahmen ihrer Leistungsverpflichtung eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse entsprechende pflegerische Versorgung der Versicherten zu gewährleisten (Sicherstellungsauftrag). Sie schließen hierzu Versorgungsverträge sowie Vergütungsvereinbarungen mit den Trägern von Pflegeeinrichtungen (§ 71) und sonstigen Leistungserbringern. Dabei sind die Vielfalt, die Unabhängigkeit und Selbständigkeit sowie das Selbstverständnis der Träger von Pflegeeinrichtungen in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben zu achten.

(2) Bei ihren Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 und 2 haben die Pflegekassen insbesondere Erkenntnisse aus ihrer Evaluation der regionalen Versorgungssituation, aus den Empfehlungen der Ausschüsse nach § 8a Absatz 1 und, soweit diese in den Ländern bestehen, der Ausschüsse nach § 8a Absatz 2 und 3 sowie Erkenntnisse aus Anzeigen von Pflegeeinrichtungen nach § 73a Absatz 1 zu berücksichtigen. Grundlage der Evaluation sind die Vorgaben nach § 113b Absatz 4 Satz 2 Ziffer 7. Ist es zur Gewährleistung des Sicherstellungsauftrags erforderlich, haben die Pflegekassen Verträge mit Einzelpflegepersonen gemäß § 77 Absatz 1 abzuschließen oder diese gemäß § 77 Absatz 2 selbst anzustellen.

2. In Artikel 1 Nummer 62 wird in Buchstabe c nach dem Doppelbuchstabe aa der Dreifachbuchstabe aaa eingefügt:

, aaa) Nach Satz 2 Nummer 6 wird folgende Nummer 7 eingefügt:

„7. Bis zum (6 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes) sind Kriterien für die Evaluation der regionalen Versorgungssituation nach § 69 Abs 2 Satz 1 vorzulegen, anhand derer für die einzelnen Leistungsarten des Dritten Abschnittes die Feststellung einer Unterversorgung bestimmt werden können.“

Begründung:

Erstmals wird im vorliegenden Gesetzentwurf durch den neuen Absatz 2 in § 69 festgelegt, dass die Pflegekassen bei ihren Aufgaben auch Erkenntnisse aus ihrer Evaluation der regionalen Versorgungssituation zu berücksichtigen haben. Im weiteren Verlauf des neuen Absatz 2 werden erstmals Handlungsoptionen bei Unterversorgung beschrieben, bis zur Einstellung von eigenem Personal.

Die Evaluation ist allerdings nicht an definierte Kriterien oder Maßzahlen gebunden. Dies bedeutet, dass es keine verlässliche Definition von pflegerischer Unterversorgung gibt, die zu verbindlichem Handeln führen muss. Dazu wäre es aber wichtig, bundeseinheitliche Kriterien für die Definition von pflegerischer Unterversorgung in zu bestimmenden Regionen, differenziert nach ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege als Grundlage für die Kategorisierung vorzuhalten.

Von daher wird vorgeschlagen, den Qualitätsausschuss nach § 113b SGB XI mit der Aufgabe zu betrauen, eine Definition von regionaler pflegerischer Unterversorgung anhand von Maßzahlen, Kriterien oder Verhältniszahl zu entwickeln, um die im Gesetz formulierte Evaluation der Versorgungssituation abgesichert vornehmen zu können.

Mit einer klaren Definition der Kriterien der Versorgungslage, die sich auf bestimmte räumliche Größen bezieht, entsteht ein regionaler Handlungsbedarf zur Sicherstellung. Dies könnte ein Ausgangspunkt für eine regionale Bedarfsplanung sein und zu einer regionalen Struktur der pflegerischen Versorgungsplanung führen, die nach Möglichkeit abgestimmt sein sollte mit der medizinischen Versorgungsplanung.